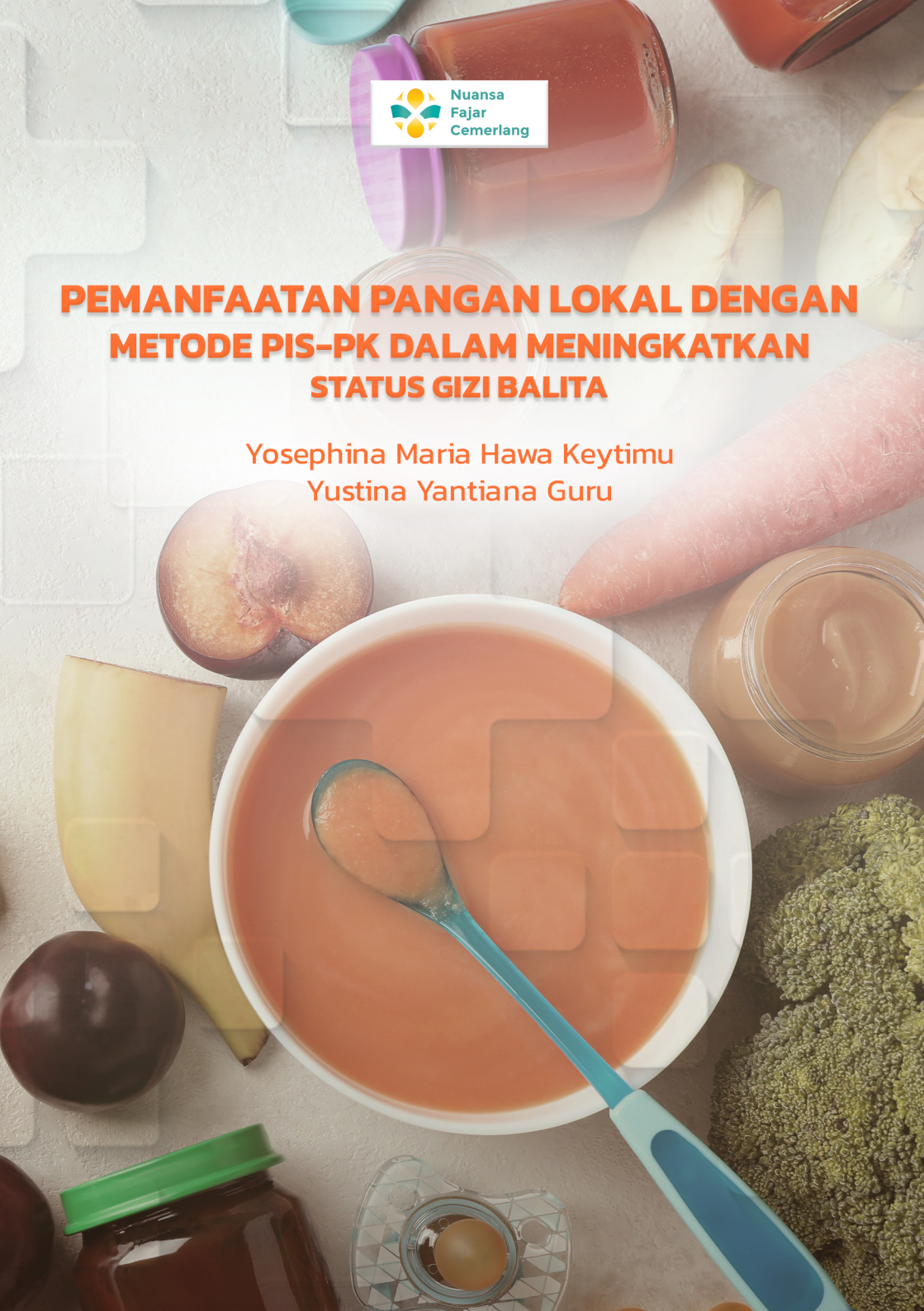




Nuansa
Fajar
Cemerlang

PEMANFAATAN PANGAN LOKAL DENGAN METODE PIS-PK DALAM MENINGKATKAN STATUS GIZI BALITA

Yosephina Maria Hawa Keytimu
Yustina Yantiana Guru



PEMANFAATAN PANGAN LOKAL DENGAN METODE PIS- PK DALAM MENINGKATKAN STATUS GIZI BALITA

**Yosephina Maria Hawa Keytimu, S.Kep., Ns., M.P.H.
Yustina Yantiana Guru, S.Kep., Ns., M.Kep.**



**Nuansa
Fajar
Cemerlang**

**Pemanfaatan Pangan Lokal dengan Metode PIS-PK
dalam Meningkatkan Status Gizi Balita**

Penulis: Yosephina Maria Hawa Keytimu, S. Kep., Ns., M.P.H.
Yustina Yantiana Guru, S. Kep., Ns., M.Kep.

Desain Sampul : Raden Bhoma Wikantioso Indrawan
Tata Letak : Achmad Faisal

ISBN: 978-634-7097-61-3
Cetakan Pertama: Februari, 2025
Hak Cipta 2025

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang
Copyright © 2025
by Penerbit Nuansa Fajar Cemerlang Jakarta
All Right Reserved

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.
Website : www.nuansafajarcemerlang.com
Instagram: @bimbel.optimal



PENERBIT:
Nuansa Fajar Cemerlang
Grand Slipi Tower, Lantai 5 Unit F
Jakarta Barat, 11480
Anggota IKAPI (624/DKI/2022)

Perpustakaan Nasional RI : Katalog Dalam Terbitan (KDT)

JUDUL DAN PENANGGUNG JAWAB	Pemanfaatan pangan lokal dengan metode PIS-PK dalam meningkatkan status gizi balita / penulis, Yosephina Maria Hawa Keytimu, S. Kep., Ns., M.P.H., Yustina Yantiana Guru, S. Kep., Ns., M.Kep.
EDISI	Cetakan Pertama, Februari, 2025
PUBLIKASI	Jakarta Barat : PT Nuansa Fajar Cemerlang, 2025
DESKRIPSI FISIK	vi, 80 halaman : ilustrasi ; 30 cm
IDENTIFIKASI	ISBN 978-634-7097-61-3
SUBJEK	Gizi anak -- Nutrisi -- Antropometri -- Makanan, Persediaan
KLASIFIKASI	353.56 [23]
PERPUSNAS ID	https://isbn.perpusnas.go.id/bo-penerbit/penerbit/isbn/data/view-kdt/1180021

Prakata

Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas perkenanNya kami dapat menyelesaikan penulisan buku ini, yang berjudul "**Pemanfaatan Pangan Lokal dengan Metode PIS-PK dalam Meningkatkan Status Gizi Balita**". Buku ini dibuat berdasarkan rasa peduli terhadap pentingnya peran Ibu dalam memanfaatkan Pangan Lokal demi meningkatkan Status Gizi balita.

Permasalahan gizi pada balita merupakan permasalahan yang bukan hanya masalah kesehatan, namun sudah menjadi masalah sosial yang wajib ditanggulangi secara bersama-sama oleh semua pihak. Oleh karena itu, pemanfaatan pangan lokal menggunakan pendekatan PIS-PK menjadi salah satu alternatif pemecahan masalah gizi agar status gizi anak menjadi baik. Buku ini diharapkan menjadi panduan praktis bagi keluarga khususnya Ibu balita dalam memahami konsep PIS-PK dan mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari.

Buku ini disusun melalui pendekatan yang terintegrasi, melibatkan berbagai aspek kesehatan seperti berat badan anak, pengetahuan ibu, faktor-faktor yang menjadi penyebab gizi kurang, pemanfaatan pangan lokal serta pendekatan keluarga. Kami berupaya semaksimal mungkin untuk menyajikan informasi yang mudah dipahami berbasis bukti dan aplikatif sehingga dapat menjangkau berbagai kalangan dengan latar belakang yang berbeda.

Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah mendukung proses penulisan buku ini. Terima kasih kami ucapkan bagi rekan sejawat, pakar kesehatan, para pembuat kebijakan, keluarga dan masyarakat yang telah memberikan informasi, inspirasi, masukan serta kritik

dan saran. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Penerbit yang telah mempercayakan kami untuk menerbitkan buku ini.

Sebagai penutup, kami mengharapkan agar buku ini dapat memberikan manfaat nyata dalam upaya meningkatkan status gizi balita menggunakan bahan dasar pangan lokal melalui pendekatan keluarga. Kami juga menyadari bahwa buku ini masih memiliki banyak kekurangan, oleh karena itu kami mengharapkan kritik dan saran dari pembaca demi perbaikan di masa yang akan datang.

Selamat membaca, semoga buku ini bermanfaat bagi kita semua.

Desember, 2024

Penulis

Daftar Isi

Prakata.....	iii
---------------------	------------

Daftar Isi.....	v
------------------------	----------

Bab 1 Pendahuluan	1
--------------------------------	----------

Bab 2 Status Gizi Kurang	6
---------------------------------------	----------

A. Konsep Balita Gizi Kurang	6
------------------------------------	---

B. Gizi Seimbang Bagi Balita.....	26
-----------------------------------	----

C. Manfaat Gizi Balita	31
------------------------------	----

D. Susunan Menu Yang Mengandung Gizi Seimbang Bagi Balita.....	33
---	----

E. Susunan Menu Yang Mengandung Gizi Seimbang Bagi Balita.....	36
---	----

F. Dampak Kekurangan Gizi pada Balita.....	38
--	----

G. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Status Gizi Balita	39
--	----

Bab 3 Pangan Lokal.....	43
--------------------------------	-----------

A. Pengertian Pangan Lokal	43
----------------------------------	----

B. Tanaman Pangan Utama di Indonesia.....	44
---	----

C. Manfaat Diversifikasi Pangan Lokal Terhadap Kesehatan	48
---	----

Bab 4 Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan	
--	--

Keluarga (PIS-PK)	54
--------------------------------	-----------

A. Pengertian PIS-PK.....	54
---------------------------	----

B. Prinsip - Prinsip Pelaksanaan PIS-PK.....	56
--	----

C. Penanggung Jawab Monitoring dan Evaluasi.....	57
--	----

D. Mekanisme Monitoring dan Evaluasi PIS-PK	58
---	----

E. Tahap Pelaksanaan Pelatihan Keluarga Sehat dalam mendukung PIS-PK.....	59
--	----

Bab 5 Penutup 69

Daftar Pustaka 72

Glosarium 76

Profil Penulis..... 78

Bab 1

Pendahuluan

Nutrisi merupakan salah satu faktor dalam mencapai kesehatan yang optimal. Status gizi mempengaruhi tumbuh kembang anak, imunitas tubuh, kecerdasan, dan produktivitas. Status gizi yang buruk menyebabkan menurunnya kualitas sumber daya manusia. Namun di berbagai wilayah Indonesia, gizi kurang masih banyak terjadi akibat ketidaksesuaian antara jumlah makanan yang dikonsumsi dengan jumlah yang dibutuhkan tubuh, serta buruknya kualitas makanan.

Menurut Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat & Direktur Gizi Masyarakat (2020), gizi kurang yaitu keadaan gizi balita yang ditandai oleh satu atau lebih tanda berikut: 1) BB/PB atau BB/TB berada pada -3 sampai dengan kurang dari -2 standar deviasi (-3 SD sd <-2 SD); 2) lingkaran lengan atas (LiLA) kurang dari 12,5 cm sampai dengan 11,5 cm pada balita usia 6-59 bulan (Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat & Direktur Gizi Masyarakat, 2020)

Selain itu, perlu dipastikan bahwa anak mendapat makanan lengkap sejak dini, sejak dalam kandungan, atau yang disebut dengan 1000 HPK. 1000 HPK dimulai sejak usia kehamilan (270 hari) hingga anak berusia 2 tahun (730 hari). Masalah gizi pada masa kehamilan berkaitan dengan status gizi seorang wanita sebelum hamil. Hal ini sebenarnya menentukan awal perkembangan plasenta dan embrio. Berat badan ibu saat hamil, baik kurus maupun kelebihan berat badan, dapat memicu

kehamilan yang berbahaya dan mempengaruhi kesehatan anak di masa depan.

Salah satu sasaran indikator strategis sesuai kebijakan RPJMN 2020-2024 yaitu penurunan prevalensi wasting dari 10,2% menjadi 7%. Balita dengan gizi kurang perlu penanganan secara tepat dan cepat guna menghindari komplikasi lanjut seperti mengancam potensi anak dan keberlangsungan hidup dan perbaikan tumbuh kembang di masa yang akan datang (Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat & Direktur Gizi Masyarakat, 2020). Masalah wasting yaitu gizi kurang akan gizi buruk tidak boleh diabaikan. Upaya-upaya pencegahan salah satunya deteksi dini berupa pemantauan pertumbuhan yang rutin dilaksanakan secara mandiri di rumah dan posyandu diharapkan dapat mengatasi permasalahan gizi kurang pada balita (UNICEF, 2024b)

Intervensi berbasis komunitas saat ini terutama menargetkan anak-anak yang lebih tua, melewati jendela pencegahan kritis dan tindakan dini. Secara global, sangat penting perlunya mengoptimalkan hasil gizi bagi kelompok rentan ini, sebagaimana dibuktikan oleh pedoman dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), strategi No Time to Waste UNICEF, dan inisiatif seperti Manajemen Bayi Kecil dan Berisiko Gizi di bawah Enam Bulan dan Ibunya (MAMI). Mengatasi kekurangan gizi ibu sangat penting, mengingat hubungannya dengan hasil kehamilan yang merugikan dan risiko yang tinggi bagi bayi, terutama di negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah yang mengharuskan adanya dukungan komprehensif untuk kesehatan fisik dan mental. (UNICEF, 2024a)

Berbagai inisiatif dilakukan untuk meningkatkan kualitas dan meningkatkan akses melalui kolaborasi lintas sektor dan lintas program, termasuk Program Indonesia Sehat Pendekatan

Keluarga (PIS-PK) yang bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan dan gizi. Pemberdayaan masyarakat didukung oleh perlindungan finansial dan pemerataan pelayanan kesehatan. Pendekatan keluarga merupakan salah satu cara yang dilakukan Puskesmas untuk memperluas cakupannya dengan mengunjungi keluarga dan mendekatkan/meningkatkan akses terhadap pelayanan kesehatan di wilayah kerjanya. Dengan program ini, Puskesmas tidak hanya memberikan pelayanan Kesehatan kepada orang di dalam gedung, namun juga di luar gedung dengan mengunjungi keluarga di wilayah kerjanya. PIS-PK juga menekankan peran inti puskesmas dalam promosi dan pencegahan (Hartati et al., 2021)

PIS-PK merupakan program "Indonesia Sehat" yang merupakan salah satu program Agenda Nawa Chita ke-5 yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia. Program ini merupakan program utama pembangunan kesehatan yang dilaksanakan dalam kerangka Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2015-2019 yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Nomor HK. 02. 02/Menkes/52/2015. Program Indonesia Sehat dilaksanakan dengan mempertahankan tiga pilar utama: Hal tersebut adalah: (1) implementasi paradigma kesehatan, (2) penguatan pelayanan kesehatan, dan (3) implementasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) (Kementerian Kesehatan, 2024)

PIS-PK dengan pendekatan keluarga merupakan evolusi dari kunjungan rumah oleh puskesmas dan perpanjangan inisiatif kesehatan masyarakat (Perkesmas) dengan kegiatannya adalah sebagai berikut: Kunjungan keluarga untuk pendataan/pengumpulan data Profil Kesehatan Keluarga dan peremajaan (updating) pangkalan datanya, melakukan kunjungan keluarga dalam rangka promosi kesehatan sebagai

upaya promotif dan preventif, kunjungan keluarga untuk menindaklanjuti pelayanan kesehatan dalam gedung. Pemanfaatan data dan informasi dari Profil Kesehatan Keluarga untuk pengorganisasian/ pemberdayaan masyarakat dan manajemen Puskesmas. Ketika masalah kesehatan teridentifikasi dalam sebuah keluarga, staf secara bersamaan menerapkan intervensi langsung tergantung pada identifikasi masalah, menerapkan promosi kesehatan dan tindakan pencegahan, dan menindaklanjuti dengan layanan di dalam gedung. Kunjungan rumah direncanakan dan dijadwalkan dengan menggunakan data dan informasi dari Prokesga. Kegiatan ini bukan untuk menghancurkan pendekatan kesehatan berbasis masyarakat (UKBM) yang sudah ada, melainkan untuk memperkuat UKBM yang selama ini dinilai kurang efektif.

Mengingat manfaat PIS-PK, maka kegiatan ini harus dilaksanakan dengan baik. Namun beberapa sumber menyebutkan bahwa penerapan PIS-PK di berbagai daerah masih kurang optimal. Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan PIS-PK tahun 2016 yang dilakukan oleh Puslitbangkesmas di berbagai kabupaten/kota, dari kabupaten/kota yang melaksanakan PIS-PK, hanya kabupaten/kota yang melakukan persiapan awal dan pendataan kota saja. Persiapan pelayanan kesehatan umum hanya sebatas pengiriman personel untuk mengikuti pelatihan bersama pimpinan puskesmas dalam persiapan dan pelaksanaan kunjungan rumah.

Hal ini diperparah sebab PIS-PK belum dijadikan prioritas serta para staf/pemegang program PIS-PK telah melaporkan hasil PIS-PK namun Kepala Dinas Kesehatan kabupaten/kota belum mendapatkan hasil laporan tersebut. Kendala lainnya berupa dana yang belum cair serta ketersediaan sumber daya tenaga yang masih kurang dan dukungan lintas disiplin ilmu yang belum maksimal. Hasil serupa juga ditunjukkan dalam

survei angkatan kerja. Pada bidang kesehatan (RISNAKES) pada tahun 2017, hanya 33,5% Puskesmas yang memiliki pegawai, pengurus, dan sarana dan prasarana penunjang PIS-PK (Hartati et al., 2021)

Makanan lokal memang beragam, namun cara dan lama penyiapannya menentukan ketersediaan nutrisi yang dikandungnya. Suplemen makanan juga dapat berupa makanan tambahan yang diproduksi secara industri. Lebih praktis dan komposisi nutrisinya lebih baik. PMT akan diberikan kepada bayi gizi buruk dan kurang gizi, namun hanya bersifat suplemen, bukan pengganti makanan pokok. Hingga saat ini, program PMT utama pemerintah masih berupa makanan olahan seperti biskuit yang difortifikasi khusus dengan vitamin dan mineral (Nelista & Fembi, 2021). Padahal, PMT dapat diolah dengan menggunakan bahan pangan yang terjangkau, memperhatikan kandungan energi, protein, dan zat gizi mikro yang tinggi, serta sesuai dengan pangan lokal yang tersedia untuk anak balita gizi buruk. Perlu dikembangkan pemanfaatan makanan tambahan berbasis bahan lokal agar orang tua dapat mandiri menyiapkan makanan bergizi.

Bab 2

Status Gizi Kurang

A. Konsep Balita Gizi Kurang

- 1 Konsep Balita
 - a. Pengertian

Balita adalah kelompok anak yang berada pada rentang usia 0-5 tahun. Masa balita merupakan periode penting dalam proses tumbuh kembang manusia dikarenakan tumbuh kembang berlangsung cepat (Herrera-Cuenca, 2021). Balita adalah istilah umum bagi anak usia 1-3 tahun (batita) dan anak prasekolah (3-5 tahun). Saat usia batita, anak masih tergantung penuh kepada orang tua untuk melakukan kegiatan penting seperti mandi, buang air dan makan. Perkembangan berbicara dan berjalan sudah bertambah baik. Namun, kemampuan lain masih terbatas (Troeger et al., 2018). Masa balita merupakan periode penting dalam proses tumbuh kembang manusia. Perkembangan dan pertumbuhan dimasa itu menjadi penentu keberhasilan pertumbuhan dan perkembangan anak di periode selanjutnya (dr. Makarim, 2024)

b. Karakteristik Balita

Balita adalah anak usia kurang dari lima tahun sehingga bayi usia di bawah satu tahun juga termasuk golongan ini. Balita usia 1-5 tahun dapat dibedakan menjadi dua, yaitu anak usia lebih dari satu tahun sampai tiga tahun yang dikenal dengan batita dan anak usia lebih dari tiga tahun sampai lima tahun yang dikenal dengan usia pra sekolah (*Toddlers_Psychology Today*, 2020).

Menurut karakteristik, balita terbagi dalam dua kategori, yaitu anak usia 1-3 tahun (batita) dan anak usia pra sekolah. Anak usia 1-3 tahun merupakan konsumen pasif, artinya anak menerima makanan dari apa yang disediakan oleh ibunya (UNICEF Parenting, 2020). Laju pertumbuhan masa batita lebih besar dari masa usia pra sekolah sehingga diperlukan jumlah makanan yang relatif besar. Pola makan yang diberikan sebaiknya dalam porsi kecil dengan frekuensi sering karena perut balita masih kecil sehingga tidak mampu menerima jumlah makanan dalam sekali makan (*Toddlers_Psychology Today*, 2020), sedangkan pada usia pra sekolah anak menjadi konsumen aktif. Mereka sudah dapat memilih makanan yang disukainya. Pada usia ini, anak mulai bergaul dengan lingkungannya atau bersekolah playgroup sehingga anak mengalami beberapa perubahan dalam perilaku. Pada masa ini anak akan mencapai fase gemar memprotes sehingga mereka akan mengatakan “tidak” terhadap ajakan. Pada masa ini berat badan anak cenderung mengalami penurunan, ini terjadi akibat dari aktifitas yang mulai banyak maupun penolakan pada makanan (CDC, 2024)

c. Berat Badan Normal Pada Balita (1-5 tahun)

Berat badan normal balita adalah salah satu aspek yang digunakan untuk menentukan status gizi anak. Peningkatan berat badan pada anak biasanya terjadi secara signifikan pada usia 1 tahun, umumnya tiga kali lipat dari berat lahirnya. Setelahnya, penambahan berat badan anak tidak begitu signifikan, bahkan dapat mengalami penurunan (WHO, 2019)

Kementerian Kesehatan RI telah mengeluarkan panduan berat badan normal anak sesuai umur (BB/U) yang tertuang dalam Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1995/Menkes/SK/XII/2010 mengenai Standar Antropometri Penilaian Status Gizi Anak. Panduan dalam Keputusan Kementerian Kesehatan tersebut juga sudah disesuaikan dengan panduan berat badan ideal balita menurut WHO (*World Health Organization*) Selain dari usianya, berat badan normal anak juga dibedakan berdasarkan jenis kelaminnya. Dalam artian, berat badan normal balita laki-laki 1 tahun tidak sama dengan berat badan normal balita perempuan 1 tahun.

Berikut ini berat badan normal balita laki-laki berdasarkan usianya (Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan, 2019)

- 1) 1 tahun: 7,7–12 kg
- 2) 1 tahun, 6 bulan: 8,8–13,7 kg
- 3) 2 tahun: 9,7–15,3 kg
- 4) 2 tahun, 6 bulan: 10,5–16,9 kg
- 5) 3 tahun: 11,3–18,3 kg
- 6) 3 tahun, 6 bulan: 12–19,7 kg
- 7) 4 tahun: 12,7–21,2 kg

8) 4 tahun, 6 bulan: 13,4–22,7 kg

9) 5 tahun: 14,1–24,2 kg

Berat badan ideal balita perempuan berdasarkan usianya adalah sebagai berikut:

1) 1 tahun: 7–11,5 kg

2) 1 tahun, 6 bulan: 8,1–13,2 kg

3) 2 tahun: 9–14,8 kg

4) 2 tahun, 6 bulan: 10–16,5 kg

5) 3 tahun: 10,8–18,1 kg

6) 3 tahun, 6 bulan: 11,6–19,8 kg

7) 4 tahun: 12,3–21,5kg

8) 4 tahun, 6 bulan: 13–23,2 kg

9) 5 tahun: 13,7–24,9 kg

d. Tumbuh Kembang Balita

Menurut (CDC, 2022) tumbuh kembang balita adalah sebagai berikut:

1) Pertumbuhan

Pengukuran antropometri yang dilakukan untuk mengukur pertumbuhan meliputi pengukuran berat badan, tinggi badan (panjang badan), lingkar kepala merupakan parameter untuk menilai pertumbuhan anak. Hasil peningkatan atau penurunan semua jaringan yang ada pada tubuh dapat dinilai dengan melakukan pengukuran berat badan. Status perbaikan gizi disamping faktor genetik dapat dinilai dengan melakukan pengukuran tinggi badan. Pertumbuhan otak dapat dinilai dengan melakukan pengukuran lingkar kepala. Retardasi mental dapat terjadi karena pertumbuhan otak yang kecil, sedangkan

peningkatan volume kepala terjadi akibat penyumbatan cairan serebrospinal.

e. Perkembangan

- 1) Perkembangan motorik kasar (gross motor) merupakan kemampuan fisik tubuh anak yang kerjanya menggunakan aktivitas otot besar, contohnya berjalan, melompat, berlari.
- 2) Perkembangan motorik halus (fine motor Skills) merupakan kemampuan tubuh anak yang kerjanya menggunakan otot kecil serta mengandalkan kecermatan dan koordinasi mata dan gerakan tangan.
- 3) Perkembangan bahasa (language) merupakan kemampuan anak dalam memberikan respon terhadap suara, mengikuti perintah dan dan berbicara spontan.
- 4) Perkembangan perilaku sosial kemandirian (personal sosial) merupakan aspek perkembangan yang berhubungan dengan keterampilan dalam melakukan tugas secara mandiri, dan mampu bersosialisasi serta berinteraksi dengan lingkungannya (Atrium Health, 2021)

f. Kebutuhan Dasar Perkembangan Balita

Kebutuhan dasar dalam tumbuh kembang balita dibagi menjadi tiga yaitu kebutuhan asah, asih, dan asuh:

- 1) Kebutuhan Fisik-Biologis (Asuh):
Kebutuhan ini merupakan kebutuhan primer balita yang meliputi:
 - a) Nutrisi: kebutuhan nutrisi dimulai sejak berada di dalam rahim. Sejak kehamilan, ibu

memberikan nutrisi kepada bayinya, setelah 9 bulan, lahir diberikan ASI eksklusif, kemudian diberikan makanan dengan nutrisi seimbang.

- b) Imunisasi: sejak lahir balita membutuhkan imunisasi guna melakukan pencegahan penyakit menular seperti TBC, pifteri, pertusis, tetatus, polio, hepatitis B.
 - c) Kebersihan: meliputi kebersihan yang berhubungan dengan hygiene makanan, minuman yang sehat, udara yang bersih, pakaian bersih, rumah dan sekolah yang bersih, tempat bermain dan transportasi yang bebas dari kotoran.
 - d) Aktifitas: balita tidak hanya membutuhkan aktivitas fisik, tetapi juga membutuhkan istirahat tidur, bermain, terutama balita karena masa ini merupakan masa bermain.
 - e) Pelayanan kesehatan: pemantauan pertumbuhan dan perkembangan balita dilakukan secara rutin dan teratur, diawali dengan penimbangan balita yang harus dilakukan minimal 8 kali dalam setahun, melakukan deteksi dini tumbuh kembang sebanyak 2 kali dalam setahun untuk mendeteksi secara adanya kelainan tumbuh kembang agar dapat diatasi sedini mungkin (Kemenkes R1, 2019).
- 2) Kebutuhan kasih sayang dan emosi (Asih):
Kebutuhan emosional balita seharusnya diberikan sejak lahir dengan membangun ikatan emosional antara orang tua dan balita, terutama ibu. Tindakan yang dapat dilakukan untuk membangun ikatan

emosional antara orang tua dengan balita adalah dengan cara:

- a) Memberikan rasa aman dan nyaman sehingga anak merasa dilindungi,
- b) Memperhatikan keinginan, minat, dan pendapat dari anak
- c) Memberikan contoh lebih baik daripada memeriksa
- d) Membantu, mendorong, dan menghargai anak
- e) Mendidik anak dengan penuh kasih sayang, bukan ancaman (Kemenkes R1, 2019).

3) Kebutuhan Stimulasi (Asah)

Segala bentuk perkembangan balita tidak dapat terjadi begitu saja tanpa adanya stimulasi. Stimulasi perkembangan perlu dilakukan karena:

- a) Sejak dalam kandungan usia 24 minggu telah terbentuk milyaran sel otak yang belum memiliki sinaps
- b) Hubungan antar sel otak dapat dibentuk dengan stimulasi dari orang tua
- c) Setiap stimulasi dilakukan akan menimbulkan sinaps baru
- d) Semakin sering dirangsang akan semakin kuat hubungan antar sel otak
- e) Semakin banyak variasi dalam melakukan stimulasi, maka hubungan antar sel otak akan semakin kompleks/luas
- f) Otak kiri dan kanan harus distimulasi secara seimbang untuk mengembangkan multipel inteligen dan kecerdasan yang lebih luas dan tinggi-stimulasi mental secara dini akan mengembangkan mental-psikososial anak

seperti: kecerdasan, budi luhur, moral, agama dan etika, kepribadian, kemampuan bahasa, kemandirian, kreativitas, produktifitas, dan perkembangan lain juga perlu distimulasi (Kemenkes R1, 2019)

2 Konsep Status Gizi

a. Pengertian

Istilah gizi berasal dari bahasa Arab “giza” yang berarti zat makanan, dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah nutrition yang berarti bahan makanan atau zat gizi atau sering diartikan sebagai ilmu gizi. Lebih luas, gizi diartikan sebagai suatu proses organisme menggunakan makanan yang dikonsumsi secara normal melalui proses pencernaan, penyerapan, transportasi, penyimpanan, metabolisme dan pengeluaran zat gizi untuk mempertahankan kehidupan, pertumbuhan dan fungsi normal organ tubuh serta untuk menghasilkan tenaga (Nuryuliani, 2024).

Status gizi adalah ekspresi dari keadaan keseimbangan dalam bentuk variabel tertentu atau dapat dikatakan bahwa status gizi merupakan indikator baik buruknya penyediaan makanan sehari-hari. Status gizi yang baik diperlukan untuk mempertahankan derajat kebugaran dan kesehatan, membantu pertumbuhan bagi anak, serta menunjang prestasi olahraga. Status gizi adalah keadaan tubuh sebagai akibat konsumsi makanan dan penggunaan zat-zat gizi yang dibedakan antara status gizi buruk, kurang, dan lebih (Lesmono, 2024)

Penilaian status gizi ada dua macam peilaian secara langsung dan tidak langsung. Penilaian status gizi secara langsung meliputi antropometri, klinis, biokomia, dan penilaian status gizi tidak langsung, meliputi statistik vital dan survei konsumsi makanan yaitu salah satu caranya metode food recall (Nuryuliani, 2024). Berdasarkan berbagai pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa status gizi merupakan kondisi tubuh sebagai gambaran konsumsi pangan dan penggunaan zat-zat gizi.

b. Indikator Status Gizi

Standar Antropometri Anak menurut (Kemenkes RI, 2020) didasarkan pada parameter berat badan dan panjang/tinggi badan yang terdiri atas (empat) indeks, meliputi:

1) Indeks Berat Badan menurut Umur (BB/U)

Indeks BB/U ini menggambarkan berat badan relatif dibandingkan dengan umur anak. Indeks ini digunakan untuk menilai anak dengan berat badan kurang (*underweight*) atau sangat kurang (*severely underweight*), tetapi tidak dapat digunakan untuk mengklasifikasikan anak gemuk atau sangat gemuk. Penting diketahui bahwa seorang anak dengan BB/U rendah, kemungkinan mengalami masalah pertumbuhan, sehingga perlu dikonfirmasi dengan indeks BB/PB atau BB/TB atau IMT/U sebelum diintervensi (Ummah, 2019)

Berat badan adalah parameter antropometri yang labil. Hasil pengukuran BB (*tissue mass*) dapat berubah relatif cepat, naik atau turun tergantung makanan anak dan status kesehatannya.

Dibandingkan dengan LLA, BB lebih cepat terpengaruh oleh perbedaan konsumsi makanan sehari-hari. Berat badan merupakan ukuran antropometri yang terpenting dan paling sering digunakan pada bayi baru lahir (neonatus). Berat badan digunakan untuk mendiagnosa bayi normal atau BBLR. Pada masa bayi-balita, berat badan dapat dipergunakan untuk melihat laju pertumbuhan fisik maupun status gizi, kecuali terdapat kelainan klinis seperti dehidrasi, asites, edema dan adanya tumor. Berat badan merupakan pilihan utama karena berbagai pertimbangan, antara lain (Ummah, 2019)

- a) Parameter yang paling baik, mudah terlihat perubahan dalam waktu singkat karena perubahan-perubahan konsumsi makanan dan kesehatan.
- b) Memberikan gambaran status gizi sekarang dan kalau dilakukan secara periodik memberikan gambaran yang baik tentang pertumbuhan.
- c) Merupakan ukuran antropometri yang sudah dipakai secara umum dan luas di Indonesia sehingga tidak merupakan hal baru yang memerlukan penjelasan secara meluas.
- d) Ketelitian pengukuran tidak banyak dipengaruhi oleh ketrampilan pengukur.
- e) KMS (Kartu Menuju Sehat) yang digunakan sebagai alat yang baik untuk pendidikan dan memonitor kesehatan anak menggunakan juga berat badan sebagai dasar pengisiannya.

- f) Karena masalah umur merupakan faktor penting untuk penilaian status gizi, berat badan terhadap tinggi badan sudah dibuktikan dimana-mana sebagai indeks yang tidak tergantung pada umur.
- g) Alat pengukur dapat diperoleh di daerah pedesaan dengan ketelitian yang tinggi dengan menggunakan dacin yang juga sudah dikenal oleh masyarakat (Hedianti et al., 2023). Penentuan berat badan dilakukan dengan cara menimbang. Alat yang digunakan di lapangan sebaiknya memenuhi beberapa persyaratan:
- (1) Mudah digunakan dan dibawa dari satu tempat ke tempat yang lain.
 - (2) Mudah diperoleh dan relatif murah harganya.
 - (3) Ketelitian penimbangan sebaiknya maksimum 0,1 kg.
 - (4) Skalanya mudah dibaca.
 - (5) Cukup aman untuk menimbang anak balita.
- Alat yang digunakan dalam penimbangan anak balita adalah dacin. Dacin yang digunakan sebaiknya minimum 20 kg dan maksimum 25 kg. Bila digunakan dacin berkapasitas 50 kg, dapat juga, tetapi hasilnya agak kasar karena angka ketelitian 0,25 kg. Jenis timbangan lain yang dapat digunakan adalah detecto. Timbangan kamar mandi atau timbangan bulat injak (*bath room scale*) tidak dapat dipakai menimbang anak balita karena menggunakan "per", sehingga hasilnya

dapat berubahubah menurut kepekaan per-nya (Hedianti et al., 2023)

- h) Indeks Panjang Badan menurut Umur atau Tinggi Badan menurut Umur (PB/U atau TB/U), Indeks PB/U atau TB/U menggambarkan pertumbuhan panjang atau tinggi badan anak berdasarkan umurnya. Indeks ini dapat mengidentifikasi anak-anak yang pendek (stunted) atau sangat pendek (severely stunted), yang disebabkan oleh berat badan kurang dalam waktu lama atau sering sakit. Anak-anak yang tergolong tinggi menurut umurnya juga dapat diidentifikasi. Anak-anak dengan tinggi badan di atas normal (tinggi sekali) biasanya disebabkan oleh gangguan endokrin, namun hal ini jarang terjadi di Indonesia (Hedianti et al., 2023)
- i) Indeks Berat Badan menurut Panjang Badan/Tinggi Badan (BB/PB atau BB/TB). Indeks BB/PB atau BB/TB ini menggambarkan apakah berat badan anak sesuai terhadap pertumbuhan panjang/tinggi badannya. Indeks ini dapat digunakan untuk mengidentifikasi anak berat badan kurang (wasted), gizi buruk (severely wasted) serta anak yang memiliki risiko berat badan lebih (possible risk of overweight). Kondisi gizi buruk biasanya disebabkan oleh penyakit dan kekurangan asupan gizi yang baru saja terjadi (akut) maupun yang telah lama terjadi (kronis) (Hedianti et al., 2023)

2) Indeks Masa Tubuh menurut Umur (IMT/U)

Indeks IMT/U digunakan untuk menentukan kategori gizi buruk, berat badan kurang, gizi baik, berisiko berat badan lebih, berat badan lebih dan obesitas. Grafik IMT/U dan grafik BB/PB atau BB/TB cenderung menunjukkan hasil yang sama. Namun indeks IMT/U lebih sensitif untuk penapisan anak berat badan lebih dan obesitas. Anak dengan ambang batas $IMT/U > +1SD$ berisiko berat badan lebih sehingga perlu ditangani lebih lanjut untuk mencegah terjadinya berat badan lebih dan obesitas (Ummah, 2019)

c. Penilaian Status Gizi

Penilaian status gizi merupakan penjelasan yang berasal dari data yang diperoleh dengan menggunakan berbagai macam cara untuk menemukan suatu populasi atau individu yang memiliki risiko status gizi kurang maupun gizi lebih, sedangkan status gizi adalah keadaan keseimbangan dalam bentuk variable tertentu atau perwujudan dari nutriture (keadaan gizi) dalam bentuk variable tertentu (kemenkes, 2023). Menurut (PSG, 2017) pada dasarnya status gizi dibagi menjadi dua yaitu secara langsung a. Penilaian Status Gizi Secara Langsung

Penilaian status gizi secara langsung dapat dibagi menjadi empat penilaian yaitu: antropometri, klinis, biokimia dan biofisik. Masing-masing penilaian tersebut akan dibahas secara umum sebagai berikut:

- 1) Antropometri merupakan pengukuran dimensi tubuh dan komposisi tubuh dari berbagai tingkat umur antara lain: Berat badan, tinggi badan, lingkaran

lengan atas dan tebal lemak di bawah kulit. Antropometri telah lama di kenal sebagai indicator sederhana untuk penilaian status gizi perorangan maupun masyarakat. Antropometri sangat umum di gunakan untuk mengukur status gizi dari berbagai ketidakseimbangan antara asupan energi dan protein. Dalam pemakaian untuk penilaian status gizi, antropometri disajikan dalam bentuk indeks yang dikaitkan dengan variabel lain. Variabel tersebut adalah sebagai berikut:

a) Umur

Umur sangat memegang peranan dalam status gizi, kesalahan penentuan akan menyebabkan interpretasi status gizi yang salah. Hasil penimbangan berat badan maupun tinggi badan yang akurat, menjadi tidak berarti bila tidak disertai dengan penentuan umur yang tepat. Kesalahan yang sering muncul adalah adanya kecenderungan untuk memilih angka yang mudah seperti 1 tahun; 1,5 tahun; 2 tahun. Oleh sebab itu penentuan umur anak perlu dihitung dengan cermat. Ketentuannya adalah 1 tahun adalah 12 bulan, 1 bulan adalah 30 hari. Jadi perhitungan umur adalah dalam bulan penuh, artinya sisa umur dalam hari tidak diperhitungkan.

b) Berat Badan

Berat badan merupakan salah satu ukuran yang memberikan Gambaran massa jaringan, termasuk cairan tubuh. Berat badan sangat peka terhadap perubahan yang mendadak baik karena penyakit infeksi maupun konsumsi makanan

yang menurun. Berat badan ini dinyatakan dalam bentuk indeks BB/U (Berat Badan menurut Umur) atau melakukan penilaian dengan melihat perubahan berat badan pada saat pengukuran dilakukan, yang dalam penggunaannya memberikan gambaran keadaan kini. Berat badan paling banyak digunakan karena hanya memerlukan satu pengukuran, hanya saja tergantung pada ketetapan umur, tetapi kurang dapat menggambarkan kecenderungan perubahan situasi gizi dari waktu ke waktu.

c) Tinggi Badan

Tinggi badan memberikan gambaran fungsi pertumbuhan yang dilihat dari keadaan kurus kering dan kecil pendek. Tinggi badan sangat baik untuk melihat keadaan gizi masa lalu terutama yang berkaitan dengan keadaan berat badan lahir rendah dan kurang gizi pada masa balita. Tinggi badan dinyatakan dalam bentuk Indeks TB/U (tinggi badan menurut umur), atau juga indeks BB/TB (Berat Badan menurut Tinggi Badan) jarang dilakukan karena perubahan tinggi badan yang lambat dan biasanya hanya dilakukan setahun sekali. Keadaan indeks ini pada umumnya memberikan gambaran keadaan lingkungan yang tidak baik, kemiskinan dan akibat tidak sehat yang menahun. Berat badan dan tinggi badan adalah salah satu parameter penting untuk menentukan status kesehatan manusia yang berhubungan dengan status gizi.

d) Indeks Antropometri:

Indeks antropometri yang umum digunakan dalam menilai status gizi adalah berat badan menurut umur (BB/U), tinggi badan menurut umur (TB/U) dan berat badan menurut tinggi badan (BB/TB). Indeks BB/U adalah pengukuran total berat badan termasuk air, lemak, tulang dan otot. Indeks tinggi badan menurut umur adalah pertumbuhan linier dan LILA adalah pengukuran terhadap otot, lemak, dan tulang pada area yang diukur.

(1) Indikator BB/U

Berat badan adalah salah satu parameter yang memberikan gambaran masa tubuh, masa tubuh sangat sensitif terhadap perubahan-perubahan yang mendadak. Berat badan adalah parameter antropometri yang sangat labil. Indikator BB/U lebih menggambarkan status gizi seseorang saat ini.

(2) Indikator TB/U

Tinggi badan merupakan antropometri yang menggambarkan keadaan tubuh skeletal. Indikator TB/U menggambarkan status gizi masa lalu. Pada keadaan normal, tinggi badan tumbuh seiring dengan pertambahan umur. Pertumbuhan tinggi badan tidak seperti berat badan, relatif kurang sensitive terhadap masalah kekurangan gizi dalam waktu pendek. Pengaruh defisiensi zat gizi terhadap tinggi badan akan nampak dalam waktu yang relatif lama.

(3) Indikator BB/TB

Berat badan memiliki hubungan yang linear dengan tinggi badan. Indeks BB/TB merupakan indikator yang baik untuk menilai status gizi saat ini (sekarang). Indeks BB/TB adalah merupakan indeks yang independen terhadap umur. Dalam keadaan normal, perkembangan berat badan akan searah dengan pertumbuhan tinggi badan dengan kecepatan tertentu.

(4) Indikator IMT/U

Faktor umur sangat penting dalam menentukan status gizi. Hasil pengukuran tinggi badan dan berat badan yang akurat, menjadi tidak berarti bila tidak disertai dengan penentuan umur yang tepat. Pengukuran status gizi balita dapat dilakukan dengan indeks antropometri dan menggunakan Indeks Massa Tubuh (IMT). Rumus perhitungan IMT sebagai berikut:

$$IMT = \frac{\text{Berat badan(kg)}}{\text{Tinggi badan (m) x Tinggi badan (m)}}$$

Pengukuran status gizi pada anak menggunakan rumus *Z-score*. Secara umum, rumus perhitungan *Z-score* adalah

$$Z\text{-score} = \frac{\text{Nilai Individu Subyek} - \text{Nilai Median Baku Rujukan}}{\text{Nilai Simpang Baku Rujukan}}$$

Nilai simpang baku rujukan disini maksudnya adalah selisih kasus dengan standar +1 SD atau -1 SD. Jadi apabila BB/TB pada kasus lebih besar daripada median, maka nilai simpang baku rujukannya diperoleh dengan mengurangi +1 SD dengan median. Tetapi

jika BB/TB kasus lebih kecil daripada median, maka nilai simpang baku rujukannya menjadi median dikurangi dengan -1 SD (Ummah, 2019)

2) Klinis

Penilaian Status Gizi secara klinis sangat penting sebagai langkah pertama untuk mengetahui keadaan gizi penduduk. Teknik penilaian status gizi juga dapat dilakukan secara klinis. Pemeriksaan secara klinis penting untuk menilai status gizi masyarakat. Metode ini didasarkan atas perubahan-perubahan yang terjadi yang dihubungkan dengan ketidakcukupan zat gizi. Hal ini dapat dilihat pada jaringan epitel seperti kulit, mata, rambut dan mukosa oral atau pada organ-organ yang dekat dengan permukaan tubuh seperti kelenjar tiroid (PSG, 2017)

Penggunaan metode ini umumnya untuk survei klinis secara cepat (*rapid clinical surveys*). Survei ini dirancang untuk mendeteksi secara cepat tanda-tanda klinis umum dari kekurangan salah satu atau lebih zat gizi. Pemeriksaan klinis terdiri dari dua bagian, yaitu:

- (a) *Medical history* (riwayat medis), yaitu catatan mengenai perkembangan penyakit.
- (b) Pemeriksaan fisik, yaitu melihat dan mengamati gejala gangguan gizi baik sign (gejala yang apat diamati) dan symptom (gejala yang tidak dapat diamati tetapi dirasakan oleh penderita gangguan gizi).

3) Secara Biokimia

Penilaian status gizi secara biokimia adalah pemeriksaan specimen yang diuji secara laboratoris yang dilakukan pada berbagai macam jaringan tubuh. Jaringan tubuh yang digunakan antara lain: darah, urine, tinja dan juga beberapa jaringan tubuh seperti hati dan otot. Salah satu ukuran yang sangat sederhana dan sering digunakan adalah pemeriksaan haemoglobin sebagai indeks dari anemia.

Metode ini digunakan untuk suatu peringatan bahwa kemungkinan akan terjadi keadaan malnutrisi yang lebih parah lagi. Banyak gejala klinis yang kurang spesifik, maka penentuan kimia faal dapat lebih banyak menolong untuk menentukan kekurangan gizi yang spesifik (PSG, 2017)

4) Secara Biofisik

Penilaian status gizi secara biofisik adalah metode penentuan status gizi dengan melihat kemampuan fungsi (khususnya jaringan) dan melihat perubahan struktur dari jaringan. Pemeriksaan fisik dilakukan untuk melihat tanda dan gejala kurang gizi. Pemeriksaan dengan memperhatikan rambut, mata, lidah, tegangan otot dan bagian tubuh lainnya (PSG, 2017).

d. Penilaian Status Gizi Secara Tidak Langsung

Penilaian status gizi secara tidak langsung dapat dibagi tiga yaitu: survei konsumsi makanan, statistik vital dan faktor ekologi. Pengertian dan penggunaan metode ini akan diuraikan sebagai berikut:

1) Survei Konsumsi Makanan

a) Pengertian Survei konsumsi makanan adalah metode penentuan status gizi secara tidak

langsung dengan melihat jumlah dan jenis zat gizi yang dikonsumsi.

- b) Penggunaan Pengumpulan data konsumsi makanan dapat memberikan gambaran tentang konsumsi berbagai zat gizi pada masyarakat, keluarga dan individu. Survei ini dapat mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan zat gizi.
- 2) Penggunaan Statistik Vital
- a) Pengertian Pengukuran status gizi dengan statistik vital adalah dengan menganalisis data beberapa statistik kesehatan seperti angka kematian berdasarkan umur, angka kesakitan dan kematian akibat penyebab tertentu dan data lainnya yang berhubungan dengan gizi.
 - b) Penggunaannya dipertimbangkan sebagai bagian dari indikator tidak langsung pengukuran status gizi masyarakat.
- 3) Penilaian Faktor Ekologi
- a) Pengertian Bengoa mengungkapkan bahwa malnutrisi merupakan masalah ekologi sebagai hasil interaksi beberapa faktor fisik, biologis dan lingkungan budaya. Jumlah makanan yang tersedia sangat tergantung dari keadaan ekologi seperti iklim, tanah, irigasi dan lain-lain.
 - b) Penggunaan Pengukuran faktor ekologi dipandang sangat penting untuk mengetahui penyebab malnutrisi di suatu masyarakat sebagai dasar untuk melakukan program intervensi gizi (Nuryuliani, 2024)

B. Gizi Seimbang Bagi Balita

1. Definisi Gizi Seimbang

Gizi seimbang adalah makanan yang terdiri dari beraneka ragam makanan dalam jumlah dan proporsi yang sesuai sehingga memenuhi gizi seseorang (Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat & Anak, 2024)

2. Pedoman Umum Gizi Seimbang

Tahun 1992 diselenggarakan kongres gizi internasional di Roma yang membahas tentang pentingnya gizi seimbang sebagai upaya untuk menghasilkan kualitas sumber daya manusia yang handal. Salah satu rekomendasi penting dari kongres tersebut adalah anjuran kepada setiap negara agar menyusun Pedoman Gizi Seimbang (PUGS). Departemen Kesehatan RI (2005) mengeluarkan pedoman praktis untuk mengatur makanan sehari-hari yang seimbang dan tertuang dalam 13 pesan dasar sebagai berikut (Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat & Anak, 2024)

a. Konsumsi makanan beraneka ragam

Tidak ada jenis makanan pun yang mengandung semua jenis zat gizi, yang mampu membuat seseorang untuk hidup sehat, tumbuh kembang dan produktif. Hal ini menyebabkan setiap orang perlu mengkonsumsi aneka ragam makanan, kecuali bayi berumur 0-6 bulan yang cukup mengkonsumsi ASI. Makanan yang beraneka ragam yaitu makanan yang mengandung unsur-unsur zat gizi yang diperlukan tubuh baik kualitas maupun kuantitasnya. Apabila terjadi kekurangan atas kelengkapan salah satu gizi tertentu pada suatu jenis makanan yang akan dilengkapi oleh gizi serupa dari makanan lain.

Mengonsumsi makanan yang beraneka ragam akan menjamin terpenuhinya kecukupan sumber zat tenaga, zat pembangun, dan zat pengatur.

- b. Konsumsi makanan untuk memenuhi kecukupan gizi
Konsumsi energi yang berlebih dapat mengakibatkan kenaikan berat badan. Energi yang berlebih di simpan sebagai cadangan didalam tubuh berbentuk lemak atau jaringan lain. Apabila keadaan ini berlanjut akan menyebabkan kegemukan, yang biasanya disertai berbagai gangguan kesehatan, seperti tekanan darah tinggi, penyakit jantung, penyakit kencing manis dan sebagainya.
- c. Makan-makanlah sumber karbohidrat, setengah dari kebutuhan energi Karbohidrat memiliki fungsi utama sebagai penyedia energi bagi tubuh. Oleh karena itulah mengonsumsi karbohidrat setengah dari kebutuhan energi yang dibutuhkan oleh tubuh dan sisanya oleh protein, lemak, vitamin, air dan mineral.
- d. Batasi konsumsi lemak seperempat sampai dari kebutuhan tubuh energi. Konsumsi lemak dan minyak dalam makanan sehari-hari sebaiknya 25-25% dari kebutuhan energi. Selain berpotensi tinggi kalori, lemak juga relatif lebih lama berada dalam system pencernaan dibandingkan dengan protein dan karbohidrat, sehingga lemak menimbulkan rasa kenyang yang lebih lama. Jika seseorang mengonsumsi lemak dan minyak secara berlebihan akan mengurangi konsumsi makanan lain sehingga menyebabkan kebutuhan gizi yang lain tidak

terpenuhi. Kebiasaan mengkonsumsi lemak hewani yang berlebihan dapat menyebabkan penyempitan pembuluh darah arteri dan penyakit jantung koroner. Resiko penyakit jantung koroner akan menurun dengan mengkonsumsi ikan karena lemak ikan mengandung asam lemak omega 3. Asam lemak omega 3 berperan dalam mencegah terjadinya penyumbatan lemak pada dinding pembuluh darah.

- e. Gunakan garam beryodium
Peraturan tertuang dalam Keppres No. 69 tahun 1994 mengharuskan semua garam yang beredar di Indonesia mengandung yodium. Kebijakan ini berkaitan erat dengan masih tingginya kejadian gangguan kesehatan akibat kekurangan yodium (GAKY) di Indonesia. Gangguan akibat kekurangan yodium merupakan masalah gizi yang serius karena dapat menyebabkan penyakit gondok dan kretin. Kekurangan unsur yodium dalam makanan sehari-hari dapat pula menurunkan tingkat kecerdasan seseorang.
- f. Makan makanan sumber zat besi (Fe)
Zat besi adalah salah satu zat penting dalam proses pembentukan sel darah merah. Sumber utama zat besi adalah bahan pangan hewani dan kacang-kacangan serta sayuran berwarna hijau. Kesulitan utama untuk memenuhi kebutuhan zat besi adalah rendahnya tingkat penyerapan zat besi dalam tubuh, terutama sumber zat besi dan nabati yang hanya diserap 1-2%. Tingkat penyerapan zat besi yang berasal dari hewani lebih tinggi daripada zat

besi yang berasal dari pangan nabati, yaitu mencapai 10-20%.

- g. Berikan ASI saja kepada bayi sampai umur 4 bulan. Pemberian ASI dapat memenuhi kebutuhan bayi sampai usia 6 bulan tanpa makanan dan minuman lain. Pada awalnya diberikan sampai 4 bulan, namun kemudian menjadi sampai 6 bulan seiring dengan berbagai penelitian yang membuktikan bahwa kebutuhan bayi sampai 6 bulan dapat tercukup hanya dengan ASI. Pemberian ASI harus segera diberikan setelah bayi dilahirkan (dalam waktu 30 menit setelah lahir). Setelah 6 bulan kepada bayi diberikan makanan pendamping dan pemberian ASI tetap diteruskan sampai bayi berumur 2 tahun.
- h. Biasakan makan pagi
Makan pagi dapat memelihara ketahanan fisik, mempertahankan daya tahan saat kerja, meningkatkan produktifitas kerja, meningkatkan konsentrasi dan memudahkan menyerap informasi. Kebiasaan makan pagi juga membantu seseorang untuk memenuhi kecukupan gizi sehari-harinya. Jenis makanan pagi dapat dipilih dan disusun sesuai keadaannya. Namun lebih baik lagi jika terdiri dari makanan sumber zat tenaga, sumber zat pembangun, dan sumber zat pengatur.
- i. Minum air bersih yang aman dan cukup jumlahnya
Cairan yang di konsumsi seseorang terutama air minum kurang dari 2 liter air setara dengan 8 gelas air sehari. Mengonsumsi cukup cairan dapat mencegah dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh dan dapat menurunkan resiko penyakit batu ginjal. Mengonsumsi cairan yang dapat terjamin

keamanannya dapat menimbulkan gangguan kesehatan seperti diare dan keracunan berbagai senyawa kimia yang terdapat dalam air.

- j. Lakukan kegiatan fisik dan olahraga secara teratur
Aktifitas fisik dapat meningkatkan kebugaran, mencegah kelebihan berat badan, meningkatkan fungsi jantung, paru dan otot serta memperlambat proses penuaan.
- k. Hindari minum minuman beralkohol
Kebiasaan minum minuman beralkohol dapat mengakibatkan terhambatnya proses penyerapan zat gizi, hilangnya zat-zat gizi yang penting, penyakit gangguan hati serta kerusakan saraf otak dan jaringan.
- l. Makan makanan yang aman bagi Kesehatan
Selain harus sehat makanan yang di konsumsi juga harus aman bagi kesehatan. Makanan yang aman adalah makanan yang bebas dari kuman dan bahan kimia berbahaya. Agar makanan dan masakan dapat memenuhi syarat-syarat halal dan aman dikonsumsi, maka makanan tersebut ditanam/diternakkan sampai siap disantap makanan harus diperlakukan dengan baik dan benar.
- m. Baca label pada makanan yang dikemas
Peraturan perundang-undangan menetapkan bahwa setiap produk makanan yang dikemas mencantumkan keterangan. Label pada makanan yang di kemas berisi keterangan tentang isi, jenis dan ukuran bahan-bahan dan yang digunakan, susunan zat gizi, tanggal kadaluarsa dan keterangan penting lain.

C. Manfaat Gizi Balita

Makanan sehari-hari yang dipilih dengan baik akan memberikan semua zat gizi yang dibutuhkan untuk fungsi normal tubuh. Begitu juga sebaliknya bila makanan tidak dipilih dengan baik akan mengalami kekurangan zat-zat gizi esensial gizi tertentu. Beberapa manfaat bagi tubuh, yaitu:

1. Memberi energi dan karbohidrat, lemak dan protein.
2. Pertumbuhan dan pemeliharaan jaringan tubuh dari mineral dan air.
3. Mengatur proses tubuh dari protein, mineral, air dan vitamin (Nasehat.id, 2022)

Kebutuhan nutrisi pada setiap anak berbeda, mengingat kebutuhan untuk pertumbuhan dan perkembangan sel atau organ pada anak berbeda. Perbedaan ini menyebabkan jumlah dan komponen zat gizi yang dibutuhkan anak juga berlainan.

Balita umumnya aktif dalam bergerak. Agar energinya tidak jadi hilang, perlu diberikan asupan makanan bergizi. Namun karena daya cernanya terbatas, sebaiknya berikan makanan yang kaya nutrisi dalam porsi sedikit (PSG, 2017)

Asupan zat-zat gizi yang lengkap masih terus dibutuhkan anak selama proses tumbuh kembang masih terus berlanjut. Zat gizi yang dibutuhkan balita ini porsi makanan yang dikonsumsi sekarang ini yang bertambah, sesuai dengan penambahan berat tubuhnya dan peningkatan proses tumbuh kembang yang terjadi. Tubuh anak tetap membutuhkan semua zat gizi utama yaitu karbohidrat, lemak, protein, serat, vitamin, dan mineral. Asupan makanan sehari untuk anak harus mengandung 10-15% kalori, 20-35% lemak, dan sisanya karbohidrat. Setiap kilogram berat badan anak memerlukan asupan energi sebanyak 100 kkal. Asupan lemak juga perlu ditingkatkan

karena struktur utama pembentuk otak adalah lemak. Lemak tersebut dapat diperoleh antara lain dari minyak dan margarine. Makanan memegang peranan penting dalam pertumbuhan fisik dan kecerdasan anak. Oleh karenanya, pola makan yang baik dan teratur perlu diperkenalkan sejak dini, antara lain dengan pengenalan jam-jam makan dan variasi makanan (Ummah, 2019)

Didalam makanan terdapat enam jenis zat gizi, yaitu karbohidrat, lemak, protein, vitamin, mineral, dan air. Zat gizi ini diperlukan bagi balita sebagai zat tenaga, zat pembangun, dan zat pengatur.

a. Zat tenaga

Zat gizi yang menghasilkan tenaga atau energi adalah karbohidrat, lemak, dan protein. Bagi balita, tenaga diperlukan untuk melakukan aktivitasnya serta pertumbuhan dan perkembangannya. Oleh karena itu, kebutuhan zat gizi sumber tenaga balita relatif lebih besar daripada orang dewasa. Informasi yang diperoleh dari survei pangan rumah tangga di Inggris memberikan gambaran tentang kontributor utama terhadap asupan energi dalam suatu populasi menyatakan bahwa:

- 1) Serelia dan produk olahannya merupakan penyedia energi utama, seperti halnya pada hampir semua negara di dunia.
- 2) Sejumlah kelompok makanan ini menyediakan jumlah energi yang hampir sama, relatif terhadap asupan keseluruhan.
- 3) Sebagian besar energi yang dikonsumsi (sekitar 80%) di suplai oleh makanan yang mengandung berbagai macam nutrisi (Ummah, 2019)

b. Zat Pembangun

Protein sebagai zat pembangun bukan hanya untuk pertumbuhan fisik dan perkembangan organ-organ tubuh balita, tetapi juga menggantikan jaringan yang haus atau rusak. Protein umumnya menyumbang 10-12 % dari energi, kecuali jika makanan pokok yang dimakan mengandung hanya sedikit protein, seperti ubi kayu, atau sejenis pisang berwarna hijau (Ummah, 2019)

c. Zat pengatur.

- 1) Zat pengatur berfungsi agar faal organ-organ dan jaringan tubuh termasuk otak dapat berjalan seperti yang diharapkan. Berikut ini zat yang berperan sebagai zat pengatur. Vitamin, baik yang larut air (vitamin B kompleks dan vitamin C) maupun yang larut dalam lemak (vitamin A, D, E, dan K).
- 2) Berbagai mineral, seperti kalsium, zat besi, iodium, dan flour.
- 3) Air, sebagai alat pengatur vital kehidupan sel-sel tubuh (Ummah, 2019)

D. Susunan Menu Yang Mengandung Gizi Seimbang Bagi Balita

Menu seimbang adalah menu yang terdiri dari beraneka ragam makanan dalam jumlah dan proporsi yang sesuai, sehingga memenuhi kebutuhan gizi seseorang guna pemeliharaan dan perbaikan sel-sel tubuh dan proses kehidupan serta pertumbuhan dan perkembangan (PSG, 2017)

Dalam menyusun menu seimbang diperlukan pengetahuan bahan makanan karena nilai gizi setiap bahan makanan tiap golongan tidak sama. Pola menu 4 sehat 5 sempurna adalah pola menu seimbang yang bila disusun

dengan baik mengandung semua zat gizi yang dibutuhkan oleh tubuh. Pada umumnya menu di Indonesia terdiri atas makanan sebagai berikut:

1. Makanan pokok untuk memberi rasa kenyang: nasi, jagung, ubi jalar, singkong, serta hasil olah seperti mie, makaroni dan sebagainya.
2. Lauk untuk memberi rasa nikmat sehingga makanan pokok yang pada umumnya mempunyai rasa netral, lebih terasa enak, terdiri-dari: lauk hewani seperti daging, ayam, ikan, telur dan sebagainya. Lauk nabati: kacang- kacangan dan hasil olah, seperti kacang kedela, kacang hijau, tahu, tempe, dan sebagainya.
3. Sayur untuk memberi rasa segar dan melancarkan proses menelan makanan karena biasanya dihidangkan dalam bentuk berkuah: sayur daun-daunan, umbi-umbian dan sebagainya.
4. Buah untuk mencuci mulut, karena menu ini terdiri atas empat macam makanan dan ternyata sehat, dalam slogan yang mudah di mengerti disebut "4 Sehat". Karena susu mengandung protein bernilai biologi tinggi dan zat-zat gizi essensial lain dalam bentuk yang mudah dicerna dan diserap, maka susu terutama dianjurkan sebagai unsur kelima bagi golongan manusia yang membutuhkan relatif lebih banyak protein yaitu balita. Dengan demikian bila menu 4 sehat ditambah dengan susu akan menjadi 5 sempurna. Kata sempurna jangan diartikan bahwa tanpa susu hidangan tidak sempurna ditinjau dari kecukupan gizi, tetapi mutu protein yang tinggi dan tersediannya zat—zat gizi lain yang mudah diserap seperti yang terdapat dalam susu akan lebih menyempurnakan mutu hidangan. Syarat menu yang baik apabila memenuhi persyaratan berikut (kemenkes, 2023):

- a. Pola menu seimbang
Pola menu seimbang diharapkan dapat memenuhi kebutuhan gizi. Susunan makanan yang dihidangkan dapat memenuhi kebutuhan gizi sesuai umur, jenis kelamin, dan juga aktifitas yang dilakukan.
- b. Aspek warna dan kombinasi Warna dan kombinasi makanan harus menarik sehingga dapat membangkitkan selera makan, namun penggunaan warna dan bahan tambahan makanan juga harus memperhatikan keamanannya dan diutamakan menggunakan pewarna alami.
- c. Tekstur dan konsistensi
Tekstur dan konsistensi yang dihidangkan disesuaikan dengan kemampuan fisiologis dan juga umur. Bentuk makanan bayi, lansia dan orang yang mengalami gangguan kesehatan khususnya dan orang yang mengalami gangguan kesehatan khususnya pencernaan akan berbeda dengan orang dewasa pada umumnya.
- d. Rasa dan aroma
Aroma masakan yang kuat dikombinasikan dengan makanan yang tidak tajam baunya. Bahan makanan seperti kol harus dikombinasikan dengan makanan segar.
- e. Ukuran dan bentuk potongan
Adanya kreasi dalam bentuk potongan dapat membangkitkan selera makan.
- f. Suhu Pertimbangkan makanan yang harus dihidangkan panas atau dingin dengan menyesuaikan suhu lingkungan, udara dan iklim. Misalnya sop atau soto enak dinikmati dalam cuaca yang dingin,

sedangkan es krim dan sop buah lebih enak jika disajikan dalam cuaca panas.

g. Penyajian menarik

Bila perlu makanan disajikan dalam bentuk hiasan dan disajikan dalam keadaan yang bersih terhindar dari pencemaran yang dapat membahayakan kesehatan.

E. Susunan Menu Yang Mengandung Gizi Seimbang Bagi Balita

Menu seimbang adalah menu yang terdiri dari beraneka ragam makanan dalam jumlah dan proporsi yang sesuai, sehingga memenuhi kebutuhan gizi seseorang guna pemeliharaan dan perbaikan sel-sel tubuh dan proses kehidupan serta pertumbuhan dan perkembangan (PSG, 2017)

Dalam menyusun menu seimbang diperlukan pengetahuan bahan makanan karena nilai gizi setiap bahan makanan tiap golongan tidak sama. Pola menu 4 sehat 5 sempurna adalah pola menu seimbang yang bila disusun dengan baik mengandung semua zat gizi yang dibutuhkan oleh tubuh. Pada umumnya menu di Indonesia terdiri atas makanan sebagai berikut (PSG, 2017):

1. Makanan pokok untuk memberi rasa kenyang: nasi, jagung, ubi jalar, singkong, serta hasil olah seperti mie, makaroni dan sebagainya.
2. Lauk untuk memberi rasa nikmat sehingga makanan pokok yang pada umumnya mempunyai rasa netral, lebih terasa enak, terdiri-dari: lauk hewani seperti daging, ayam, ikan, telur dan sebagainya. Lauk nabati: kacang- kacangan dan hasil olah, seperti kacang kedela, kacang hijau, tahu, tempe, dan sebagainya.

3. Sayur untuk memberi rasa segar dan melancarkan proses menelan makanan karena biasanya dihidangkan dalam bentuk berkuah: sayur daun-daunan, umbi-umbian dan sebagainya.
4. Buah untuk mencuci mulut, karena menu ini terdiri atas empat macam makanan dan ternyata sehat, dalam slogan yang mudah di mengerti disebut "4 Sehat". Karena susu mengandung protein bernilai biologi tinggi dan zat-zat gizi essensial lain dalam bentuk yang mudah dicerna dan diserap, maka susu terutama dianjurkan sebagai unsur kelima bagi golongan manusia yang membutuhkan relatif lebih banyak protein yaitu balita. Dengan demikian bila menu 4 sehat ditambah dengan susu akan menjadi 5 sempurna. Kata sempurna jangan diartikan bahwa tanpa susu hidangan tidak sempurna ditinjau dari kecukupan gizi, tetapi mutu protein yang tinggi dan tersediannya zat—zat gizi lain yang mudah diserap seperti yang terdapat dalam susu akan lebih menyempurnakan mutu hidangan. Syarat menu yang baik apabila memenuhi persyaratan berikut (Sulistyonongsih, 2011):
 - a. Pola menu seimbang
Pola menu seimbang diharapkan dapat memenuhi kebutuhan gizi. Susunan makanan yang dihidangkan dapat memenuhi kebutuhan gizi sesuai umur, jenis kelamin, dan juga aktifitas yang dilakukan.
 - b. Aspek warna dan kombinasi
Warna dan kombinasi makanan harus menarik sehingga dapat membangkitkan selera makan, namun penggunaan warna dan bahan tambahan makanan juga harus memperhatikan keamanannya dan diutamakan menggunakan pewarna alami.

c. Tekstur dan konsistensi

Tekstur dan konsistensi yang dihidangkan disesuaikan dengan kemampuan fisiologis dan juga umur. Bentuk makanan bayi, lansia dan orang yang mengalami gangguan kesehatan khususnya dan orang yang mengalami gangguan kesehatan khususnya pencernaan akan berbeda dengan orang dewasa pada umumnya.

d. Rasa dan aroma

Aroma masakan yang kuat dikombinasikan dengan makanan yang tidak tajam baunya. Bahan makanan seperti kol harus dikombinasikan dengan makanan segar.

e. Ukuran dan bentuk potongan

Adanya kreasi dalam bentuk potongan dapat membangkitkan selera makan.

f. Suhu Pertimbangkan makanan yang harus dihidangkan panas atau dingin dengan menyesuaikan suhu lingkungan, udara dan iklim. Misalnya sop atau soto enak dinikmati dalam cuaca yang dingin, sedangkan es krim dan sop buah lebih enak jika disajikan dalam cuaca panas.

g. Penyajian menarik

Bila perlu makanan disajikan dalam bentuk hiasan dan disajikan dalam keadaan yang bersih terhindar dari pencemaran yang dapat membahayakan kesehatan.

F. Dampak Kekurangan Gizi pada Balita

Menurut (Unika, 2006) kekurangan zat gizi secara umum dapat menyebabkan gangguan pada beberapa proses tubuh, yaitu:

1. Pertumbuhan Anak-anak yang kurang gizi tidak tumbuh menurut potensialnya.
2. Produksi tenaga. Kekurangan energi berasal dari makanan yang menyebabkan seseorang kekurangan tenaga untuk bergerak dan melakukan aktifitas. Orang menjadi malas, merasa lemah, dan produktifitas kerja menurun
3. Pertahanan tubuh. Daya tekanan dan stres menurunkan sistem imunitas dan antibodi berkurang, sehingga orang mudah terserang penyakit. Pada anak-anak hal ini menyebabkan kematian.
4. Struktur fungsi otak. Kurang gizi pada usia muda dapat berpengaruh terhadap perkembangan mental dan kemampuan berfikir. Otak mencapai bentuk maksimum pada usia 2 tahun, kurang gizi dapat mengakibatkan terganggunya fungsi otak secara permanen.

G. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Status Gizi Balita

Masalah gizi pada balita dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik factor penyebab langsung maupun faktor penyebab tidak langsung. Menurut (Herlambang et al., 2021), faktor penyebab langsung timbulnya masalah gizi pada balita adalah penyakit infeksi serta kesesuaian pola konsumsi makanan dengan kebutuhan anak, sedangkan faktor penyebab tidak langsung merupakan faktor seperti tingkat sosial ekonomi, pengetahuan ibu tentang kesehatan, ketersediaan pangan di Tingkat keluarga, pola konsumsi, serta akses ke fasilitas pelayanan. Selain itu, pemeliharaan kesehatan juga memegang peranan penting (Pratiwi, 2023)

Dibawah ini dijelaskan beberapa faktor penyebab tidak langsung masalah gizi balita.

a. Ketersediaan pangan di tingkat keluarga

Status gizi dipengaruhi oleh ketersediaan pangan ditingkat keluarga, hal ini sangat tergantung dari cukup tidaknya pangan yang dikonsumsi oleh setiap anggota keluarga untuk mencapai gizi baik dan hidup sehat (Depkes RI, 2004). Jika tidak cukup bisa dipastikan konsumsi setiap anggota keluarga tidak terpenuhi (Depkes RI, 2002). Padahal makanan untuk anak harus mengandung kualitas dan kuantitas cukup untuk menghasilkan kesehatan yang baik.

b. Pola asuh keluarga

Pola asuh keluarga adalah pola pendidikan yang diberikan oleh orang tua terhadap anaknya. Setiap anak membutuhkan cinta, perhatian, kasih sayang yang akan berdampak pada perkembangan fisik, mental dan emosional. Pola asuh terhadap anak berpengaruh terhadap timbulnya, masalah gizi. Perhatian yang cukup dan pola asuh yang tepat akan memberi pengaruh yang besar dalam memperbaiki status gizi. Anak yang mendapat perhatian lebih, baik secara fisik maupun emosional misalnya selalu mendapat senyuman, mendapat respon ketika berceloteh, mendapat ASI dan makanan yang seimbang maka keadaan gizinya lebih baik dibandingkan dengan teman sebayanya yang kurang mendapatkan perhatian orang tuanya.

c. Kesehatan lingkungan

Masalah gizi timbul tidak hanya karena dipengaruhi oleh ketidakseimbangan asupan makanan, tetapi juga dipengaruhi oleh penyakit infeksi. Masalah kesehatan lingkungan merupakan determinan penting dalam

bidang kesehatan. Kesehatan lingkungan yang baik seperti penyediaan air bersih dan perilaku hidup sehat akan mengurangi resiko kejadian penyakit infeksi. Sebaliknya lingkungan yang buruk seperti air minum tidak bersih, tidak ada saluran penampungan air limbah, tidak menggunakan kloset yang baik dapat menyebabkan penyebaran penyakit. Infeksi dapat menyebabkan kurangnya nafsu makan menjadi rendah dan akhirnya menyebabkan kurang gizi.

d. Pelayanan kesehatan dasar

Pemantauan pertumbuhan yang diikuti dengan tindak lanjut berupa konseling, terutama oleh petugas kesehatan berpengaruh pada pertumbuhan anak. Pemanfaatan fasilitas kesehatan seperti penimbangan balita, pemberian suplemen kapsul vitamin A, penanganan diare dengan oralit serta imunisasi.

e. Budaya Keluarga

Budaya berperan dalam status gizi masyarakat karena ada beberapa kepercayaan seperti tabu mengkonsumsi makanan tertentu oleh kelompok umur tertentu yang sebenarnya makanan tersebut justru bergizi dan dibutuhkan oleh kelompok umur tertentu. Unsur-unsur budaya mampu menciptakan suatu kebiasaan makan masyarakat yang kadang-kadang bertentangan dengan prinsip-prinsip ilmu gizi. Misalnya, seperti budaya yang memprioritaskan anggota keluarga untuk mengkonsumsi hidangan keluarga yang telah disiapkan yaitu umumnya kepala keluarga. Apabila keadaan tersebut berlangsung lama dapat berakibat timbulnya masalah gizi kurang terutama pada golongan rawan gizi seperti ibu hamil, ibu menyusui, bayi dan anak balita.

f. Sosial ekonomi

Banyaknya anak balita yang kurang gizi dan gizi buruk di sejumlah wilayah di tanah air disebabkan ketidaktahuan orang tua akan pentingnya gizi seimbang bagi anak balita yang pada umumnya disebabkan Pendidikan orang tua yang rendah serta faktor kemiskinan. Kurangnya asupan gizi biasanya disebabkan oleh terbatasnya jumlah makanan yang dikonsumsi atau makanannya tidak memenuhi unsur gizi yang dibutuhkan dengan alasan sosial ekonomi yaitu kemiskinan.

g. Tingkat pengetahuan dan Pendidikan

Permasalahan kurang gizi tidak hanya menggambarkan masalah kesehatan saja, tetapi lebih jauh mencerminkan kesejahteraan rakyat termasuk pendidikan dan pengetahuan masyarakat. Tingkat pendidikan akan mempengaruhi pengetahuan seseorang sehingga berpandangan luas, berfikir dan bertindak rasional (Herlambang et al., 2021)

Bab 3

Pangan Lokal

A. Pengertian Pangan Lokal

Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia. Agar kebutuhan pangan tercapai, perlu dilakukan usaha, salah satunya dengan mewujudkan ketahanan pangan. Ketahanan pangan sangat ditentukan oleh kecukupan ketersediaan pangan di masyarakat. Pangan lokal menurut (WikiPangan, 2018) adalah produk pangan yang telah lama di produksi, berkembang dan dikonsumsi di suatu daerah atau suatu kelompok masyarakat lokal tertentu. Lebih lanjut dijelaskan, pangan lokal dikembangkan sesuai preferensi konsumen lokal. Pangan lokal berkaitan dengan budaya lokal setempat yang berasal dari dalam negeri. Pangan lokal melimpah di Indonesia. (Iqrimah, 2024) menambahkan saat ini Indonesia memiliki 77 jenis pangan sumber karbohidrat, 75 jenis pangan sumber protein, 110 jenis rempah dan bumbu, 389 jenis buah-buahan, 228 jenis sayuran, 26 jenis kacang dan 40 jenis bahan minuman.

Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan,

dan/atau pembuatan makanan atau minuman. Pangan lokal adalah produk pangan yang telah lama diproduksi, berkembang dan dikonsumsi di suatu daerah atau suatu kelompok masyarakat lokal tertentu. Umumnya produk pangan lokal diolah dari bahan baku lokal, teknologi lokal, dan pengetahuan lokal pula. Pangan lokal biasanya dikembangkan sesuai dengan preferensi konsumen lokal pula. Pangan lokal ini berkaitan erat dengan tanaman budaya lokal setempat yang berasal dari dalam negeri (Sutrisno et al., 2023)

B. Tanaman Pangan Utama di Indonesia

Tanaman pangan semula adalah kelompok tanaman sumber karbohidrat dan protein. Didalam konsep konsumsi pangan harapan yang memasukkan lemak sebagai salah satu zat gizi utama, telah mengubah batasan tanaman pangan sebagai kelompok tanaman penghasil karbohidrat, protein, dan lemak. Lebih spesifik lagi, tanaman pangan adalah sekelompok tanaman semusim penghasil bahan pangan yang dibudidayakan di sawah atau tegalan. Pembatasan ini perlu untuk lebih memfokuskan arah pengembangan produksi dan pemuliaannya (Sutrisno et al., 2023)

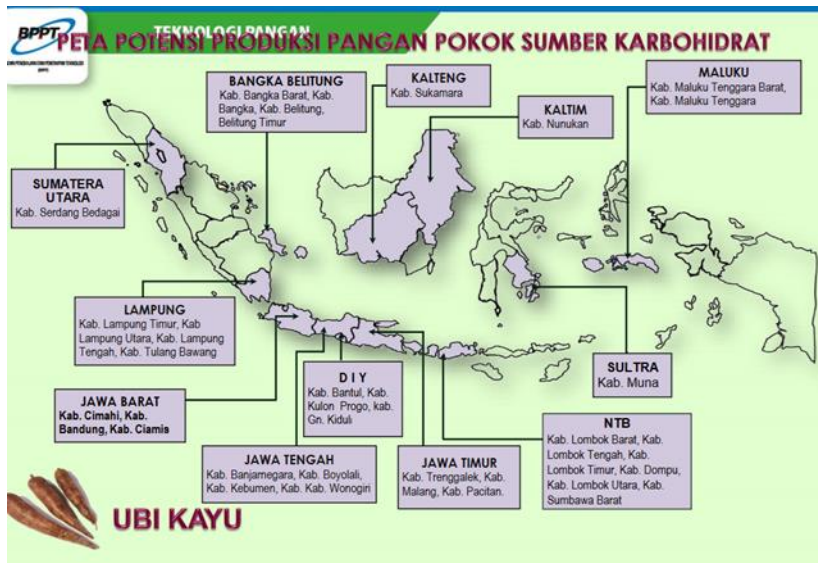
Tabel 3.1 Kandungan Karbohidrat, Protein, dan Lemak Tujuh Jenis Tanaman Pangan Utama di Indonesia

Jenis Tanaman	Kandungan gizi setiap 100g bahan mentah			
	Karbohidrat (g)	Protein (g)	Lemak (g)	Energi (kJ)
Padi (beras putih)	80.00	7.13	0.66	1.528
Jagung kuning (biji/pipilan)	74.00	9.40	4.74	1.528

Kedelai (biji tua mentah)	30.16	36.49	19.94	1.866
Kacang tanah (biji tua)	21.00	25.00	48.00	2.385
Kacang hijau (biji tua)	62.63	23.86	1.15	1.452
Ubi kayu (segar, tanpa kulit)	38.00	1.40	0.28	670
Ubi jalar (segar, tanpa kulit)	20.10	1.60	0.10	359

Padi dan jagung kuning dengan kandungan karbohidrat 80% dan 74% merupakan bahan makanan pokok penting dunia. Jagung merupakan tanaman biji-bijian yang terluas area panennya di dunia, disusul oleh padi dan gandum. Polong semusim (kedelai, kacang tanah, dan kacang hijau) lebih berperan sebagai tanaman sumber protein, terutama kedelai dan kacang hijau (Sutrisno et al., 2023)

Kacang tanah dan kedelai lebih umum dikelompokkan sebagai tanaman sumber minyak (oil crops). Ubi kayu dan ubi jalar juga menjadi tanaman sumber karbohidrat dari kelompok tanaman umbi-umbian yang dibiakkan secara klonal (vegetatif). Ubi jalar juga menjadi tanaman sumber vitamin (A dan C) dan tanaman pangan fungsional (ubi jalar ungu) karena banyak mengandung antosianin (antioksidan). Daun dan pucuk muda ubi kayu dan ubi jalar juga dikonsumsi sebagai sumber protein nabati yang cukup penting, terutama di wilayah Asia Tenggara (Sutrisno et al., 2023)



Gambar 3.1
(BPPT, 2017)



Gambar 3.2
(BPPT, 2017)



Gambar 3.3
(BPPT, 2017)



Gambar 3.4
(Pangan Lokal Pengganti Beras. Sumber, BPPT 2017)

C. Manfaat Diversifikasi Pangan Lokal Terhadap Kesehatan

Pemenuhan pangan pokok tidak hanya dipenuhi dari beras, sehingga perlu diversifikasi pangan yang telah dituangkan dalam Perpres No 22 tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal (Pusat Kesehatan dan Gizi Manusia, 2014)

Diversifikasi pangan lokal telah menjadi isu penting dalam upaya mencapai ketahanan pangan yang berkelanjutan dan peningkatan kesehatan masyarakat. Di banyak negara, termasuk Indonesia, pola makan sering kali didominasi oleh beberapa bahan pokok seperti beras atau gandum, yang menyebabkan ketergantungan tinggi terhadap satu jenis pangan. Diversifikasi pangan adalah upaya untuk memperluas spektrum sumber makanan dengan memanfaatkan berbagai jenis bahan pangan lokal yang ada di suatu daerah (Pusat Kesehatan dan Gizi Manusia, 2014)

Indonesia memiliki sagu, jagung, singkong, dan ubi jalar yang merupakan sumber pangan lokal yang melimpah. Namun kurang dimanfaatkan dan kurang dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia dibandingkan beras. Padahal jika dilihat dan diteliti lebih lanjut berbagai macam pangan lokal mulai dari umbi – umbian, buah – buahan, sayuran, kacang – kacangan, dan biji – bijian memiliki potensi besar untuk meningkatkan kualitas diet masyarakat. Diversifikasi pangan lokal tidak hanya dapat meningkatkan ketahanan pangan, namun juga dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi kesehatan, seperti meningkatkan asupan zat gizi dalam tubuh serta mencegah terjadinya penyakit dalam tubuh. Berikut pembahasan singkat berbagai manfaat dari

diversifikasi pangan lokal terhadap Kesehatan (Sutrisno et al., 2023)

1. Meningkatkan asupan zat gizi dalam tubuh

Pangan lokal lebih kaya akan kandungan gizinya karena belum mengalami proses pengolahan yang dapat mengurangi kandungan gizinya. Misalnya, umbi-umbian lokal seperti ubi jalar dan singkong kaya akan karbohidrat kompleks dan serat, sebagai sumber energi dan kesehatan pencernaan. Buah-buahan lokal seperti mangga, pisang, dan pepaya, menyediakan vitamin dan mineral penting seperti vitamin C, kalium, serta serat pangan. Demikian juga, kacang-kacangan lokal seperti kacang tanah dan kedelai kaya akan protein nabati, yang berfungsi sebagai sumber protein alternatif selain daging.

Dalam banyak kasus, masyarakat di pedesaan yang mengonsumsi makanan lokal lebih beragam cenderung memiliki pola makan yang lebih seimbang. Data dari Badan Ketahanan Pangan (BKP) 2021 menyebutkan bahwa jenis makanan padi – padian, umbi berpati serta sayur dan buah berturut – turut 4.7%, 31.1% dan 2.1% lebih banyak dikonsumsi oleh masyarakat pedesaan dibandingkan dengan masyarakat perkotaan yang lebih banyak konsumsi protein hewani, protein nabati, lemak serta minuman.

Dalam Penelitian juga menunjukkan bahwa, konsumsi beragam pangan lokal dapat membantu mencegah kekurangan mikronutrien yang sering terjadi pada masyarakat yang mengandalkan satu jenis makanan pokok, seperti nasi. Kekurangan mikronutrien ini dapat mengakibatkan masalah kesehatan serius, seperti anemia, rabun senja, serta osteoporosis.

2. Pangan Lokal Membantu Mencegah Penyakit Tidak Menular

Diversifikasi pangan lokal juga dapat berperan penting dalam pencegahan penyakit tidak menular seperti diabetes, hipertensi, dan penyakit jantung. Pola makan yang tinggi serat dari pangan lokal seperti jagung, kacang-kacangan, dan sayuran, dapat membantu mengontrol kadar gula darah dan mencegah obesitas, yang merupakan faktor risiko utama untuk diabetes tipe 2.

Dalam sebuah penelitian (Sihite, 2023) mengungkapkan bahwa, makanan lokal seperti ubi jalar, kaya akan beta-karoten dan antioksidan dapat membantu mengurangi risiko kanker serta penyakit tidak menular lainnya seperti hipertensi, darah tinggi dan obesitas. Selain itu ubi jalar ungu mengandung antosianin yang berfungsi untuk menangkap radikal bebas dalam tubuh sehingga dapat mencegah terjadinya penuaan dini, penyakit kanker, serta membantu mengontrol kadar gula dalam darah. Kemudian, buah – buahan tropis seperti manggis dan rambutan mengandung polifenol dan antioksidan yang membantu melawan peradangan dan mencegah kerusakan sel yang dapat memicu perkembangan kanker.

3. Meningkatkan Kesehatan Pencernaan

Pangan lokal yang kaya serat, seperti singkong, jagung, serta sayuran hijau lokal, berperan penting dalam menjaga kesehatan pencernaan. Serat pangan membantu memfasilitasi pergerakan usus yang sehat, mencegah sembelit, dan mendukung pertumbuhan mikrobiota usus yang sehat. Mikrobiota usus yang seimbang sangat penting untuk menjaga kekebalan tubuh serta

mengurangi resiko peradangan kronis yang dapat menyebabkan penyakit seperti kanker usus besar. Selain itu, serat pangan juga dapat membantu memperlambat penyerapan gula dalam darah, yang penting bagi penderita diabetes dalam mengontrol kadar gula darahnya.

4. Ketahanan pangan dan keberlanjutan lingkungan

Manfaat pangan lokal selain untuk kesehatan, juga berperan dalam ketahanan pangan dan keberlanjutan lingkungan. Pangan lokal sering kali lebih mudah diakses, lebih terjangkau, dan lebih sesuai dengan kondisi ekosistem setempat, sehingga tidak membutuhkan input pertanian yang tinggi seperti pupuk kimia atau pestisida. Kemudian, dengan memanfaatkan pangan lokal, masyarakat dapat meningkatkan ketahanan pangan mereka, terutama di masa krisis atau bencana alam ketika pasokan makanan dari luar daerah mungkin terganggu.

Penting bagi masyarakat Indonesia untuk mencoba memulai mengkonsumsi dan memanfaatkan pangan lokal Indonesia sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan secara umum.

5. Kreasi Pangan Lokal

Masyarakat Indonesia saat ini masih bergantung pada beras sebagai makanan pokok, padahal banyak pangan lokal non beras yang bisa menggantikan beras sebagai sumber karbohidrat. Jenis tanaman sumber karbohidrat yang bisa dimanfaatkan sebagai pengganti beras seperti sorgum, singkong, ubi jalar, kentang, pisang, talas, dan masih banyak lagi.

Perpaduan kekayaan budaya Indonesia tercermin dalam keragaman kebiasaan dan hidangan makanannya. Menciptakan kreasi menu non beras dan non terigu ala

milennial, dengan gaya dan selera milennial yang menarik diharapkan melahirkan aneka menu berbahan dasar pangan lokal non beras non terigu yang mencerminkan preferensi dari generasi milennial. Memiliki penampilan menarik, kekinian dan cita rasa lezat. Mengenalkan olahan pangan lokal, memberi inspirasi dalam pengolahan pangan lokal, serta menjadi pilihan menu bagi masyarakat luas yang ingin mengkonsumsi pangan lokal kekinian sehingga pangan lokal semakin diminati. Beberapa contoh kreasi pangan lokal ala milennial sebagai berikut:

a. Sorgum

KALUNG WITH WOKU SAUCE SORGUM LIWET AND MIX VEGETABLE

Saus woku merupakan saus nusantara yang berasal dari Indonesia tepatnya daerah Manado, Sulawesi Utara. Dalam menu ini protein yang akan digunakan yaitu Ikan kakap yang digulung dan diisi berupa sayur-sayuran dihidangkan dengan saus woku yang memiliki cita rasa pedas dan gurih disajikan dengan sorgum liwet yang diadaptasi dari nasi liwet dan memiliki cita rasa khas kaya akan rempah, dan ditambahkan dengan mix vegetable untuk menunjang hidangan tersebut. Kemudian hidangan ini juga ditambahkan keripik singkong untuk memberi tekstur saat memakannya.

b. Singkong

PAN SEARED KASUAMI, TUNA WOKU MI-CUIT, TUMIS BUNGA PEPAYA DENGAN GARNISH KERIPIK PISANG

Kasuami merupakan olahan singkong khas Sulawesi Tenggara yang biasa dijadikan pengganti nasi oleh warga Wakatobi dan Buton. Olahan Kasuami yang lembut di dalam dan renyah diluar disajikan dengan Tuna Woku khas Manado yang diolah dengan teknik

klasik ala eropa untuk menjaga kandungan nutrisi dan kualitas terbaik dari bahan lokal yang digunakan. Teknik yang simple dengan citarasa yang kaya dapat menjadi pilihan hidangan yang lezat dan mudah dibuat untuk disajikan dimanapun dan kapanpun

c. Pisang

BANANA TOFU WITH GRILL GABUS AND TONGSENG SAUCE

Tongseng adalah hidangan berkuah seperti gulai. Hidangan ini terinspirasi dari pedagang Timur Tengah yang sedang berdagang ke daerah Jawa. Kali ini tongseng tidak hanya dapat dibuat dari daging kambing, tapi bisa juga dikreasikan dengan ikan bakar. Tongseng ikan memiliki rasa manis-gurih yang kuat dari racikan lada, kemiri, bawang merah, dan bawang putih. Berpadu dengan empuknya daging ikan bakar. Pada hidangan yang kami bawakan nanti kami akan menghadirkan banana tofu yang akan kami hadirkan sebagai sumber karbohidrat pengganti nasi. Hal ini karena kami ingin memberi opsi lain sumber karbohidrat selain nasi. Selain pisang sangat mudah dijumpai, pisang juga memiliki banyak sumber vitamin yang baik untuk tubuh.

d. **SORGUM HITAM DENGAN UDANG ASAM GARAM DAN TEBU KARI HIJAU**

Udang asam garam, adalah hidangan khas Pontianak, dengan rasa gurih, dan pedas yang akan di padukan dengan telur tebu yang dimasak dengan kari hijau, dan dihidangkan dengan pengganti karbohidrat, sorgum yang dimasak dengan tinta cumi. Sorgum akan menjadi pengganti karbohidrat yang unik (Sutrisno et al., 2023)

Bab 4

Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK)

A. Pengertian PIS-PK

Arah kebijakan pemerintah dalam merumuskan berbagai macam kebijakan termasuk kebijakan dalam bidang Kesehatan terinclude dalam agenda ke 5 Nawa Cita, yang salah satunya adalah program Indonesia Sehat. Program Indonesia Sehat menjadi program utama Pembangunan Kesehatan dalam Renstra Kementerian Kesehatan tahun 2015-2019 yang penetapannya dibuat dalam Keputusan Menteri Kesehatan R.I. Nomor HK.02.02/Menkes/52/2015 (Kementerian Kesehatan, 2017)

Sasaran dari Program Indonesia Sehat adalah meningkatnya derajat kesehatan dan status gizi masyarakat melalui upaya kesehatan dan pemberdayaan masyarakat yang didukung dengan perlindungan finansial dan

pemerataan pelayanan kesehatan. Sasaran ini sesuai dengan sasaran pokok RPJMN 2015-2019, yaitu:

1. Meningkatkan status kesehatan dan gizi ibu dan anak
2. Meningkatkan pengendalian penyakit
3. Meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan dasar dan rujukan terutama di daerah terpencil, tertinggal dan perbatasan
4. Meningkatkan cakupan pelayanan kesehatan universal melalui Kartu Indonesia Sehat dan kualitas pengelolaan SJSN Kesehatan
5. Terpenuhinya kebutuhan tenaga kesehatan, obat dan vaksin, serta
6. Meningkatkan responsivitas sistem Kesehatan (Hartati et al., 2021)

PIS-PK merupakan cara bagi puskesmas untuk memperluas jangkauannya dan mengunjungi keluarga untuk mendekatkan atau meningkatkan akses terhadap layanan kesehatan di tempat kerja mereka. Puskesmas memberikan pelayanan kesehatan di dalam Gedung maupun di luar Gedung dengan cara mengunjungi keluarga di Wilayah Kerja. Penyelenggaraan program Pendekatan Keluarga Sehat Indonesia (PIS-PK) pada dasarnya merupakan pelayanan kesehatan yang berlangsung di luar gedung Puskesmas. Tim puskesmas juga dapat melakukan intervensi dini terhadap permasalahan kesehatan setiap keluarga melalui kunjungan keluarga (Kementerian Kesehatan, 2017)

Dalam Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PISPK), terdapat 12 indikator kesehatan keluarga, yaitu: keluarga berpartisipasi dalam program Keluarga Berencana (KB), ibu melahirkan di fasilitas kesehatan, bayi

menerima imunisasi dasar lengkap, bayi mendapatkan ASI eksklusif, balita dipantau pertumbuhannya, penderita tuberkulosis paru menjalani pengobatan sesuai standar, penderita hipertensi rutin menjalani pengobatan, penderita gangguan jiwa mendapatkan perawatan yang sesuai dan tidak diabaikan, tidak ada anggota keluarga yang merokok, keluarga terdaftar dalam Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), keluarga memiliki akses terhadap air bersih, serta menggunakan jamban sehat (Sari et al., 2022)

Selain 12 indikator tersebut, setiap daerah dapat menambahkan indikator tambahan sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Informasi yang diperoleh dari kunjungan rumah dicatat dalam Profil Kesehatan Keluarga (Prokesga). Jika ditemukan masalah kesehatan dalam keluarga, petugas akan memberikan intervensi langsung sesuai dengan masalah yang ditemukan, melaksanakan promosi kesehatan sebagai bagian dari upaya promotif dan preventif, serta menindaklanjuti layanan di fasilitas kesehatan. Kunjungan rumah dilakukan secara terjadwal dan rutin, dengan memanfaatkan data dan informasi dari Prokesga (family folder). Langkah ini tidak dimaksudkan untuk menggantikan Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM) yang sudah ada, melainkan untuk memperkuat efektivitas UKBM yang selama ini dirasa kurang optimal (Hartati et al., 2021)

B. Prinsip - Prinsip Pelaksanaan PIS-PK

Prinsip-prinsip pelaksanaan PIS-PK pada pelaksanaan monitoring dan evaluasi PIS-PK menurut (Kemenkes RI, 2017)], yaitu sebagai berikut:

1. Kejelasan dan tujuan hasil yang diperoleh dari kegiatan monitoring dan evaluasi
2. Menilai kondisi lapangan secara objektif
3. Melibatkan berbagai pihak yang dipandang perlu dan berkepentingan secara proaktif
4. Pelaksanaan dapat dipertanggungjawabkan secara internal dan eksternal
5. Menggambarkan secara utuh kondisi dan situasi pada setiap tahapan pelaksanaan PIS-PK (pelatihan KS, persiapan kunjungan keluarga dan intervensi awal, intervensi lanjut dan analisis hasil intervensi lanjut)
6. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi lanjut sesuai dengan jadwal lanjut yang telah ditetapkan
7. Dilaksanakan secara berkala dan berkelanjutan
8. Dilaksanakan secara terintegrasi, efektif dan efisien
9. Berorientasi peningkatan mutu/kualitas pelaksanaan PIS-PK
10. Akurasi informasi melalui verifikasi hasil kunjungan keluarga
11. Kepastian tindak lanjut

C. Penanggung Jawab Monitoring dan Evaluasi

Pelaksanaan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK) merupakan kegiatan yang terintegrasi, sehingga seluruh pihak memiliki tanggung jawab dalam keberhasilannya. Monitoring dan evaluasi PIS-PK dilakukan secara bertahap sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing tingkat penanggung jawab. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan PIS-PK berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku serta mengevaluasi kemajuan implementasinya dalam upaya mewujudkan

masyarakat Indonesia yang sehat. Distribusi penanggung jawab PIS-PK dapat dilihat pada table di bawah ini:

Tabel 4.1 Distribusi Penanggung Jawab Dalam Pemantauan dan Evaluasi PIS-PK

Unit Organisasi	Penanggungjawab
Tingkat pusat	Penanggungjawab Bina Wilayah Tingkat pusat yang ditetapkan oleh Menteri
Tingkat Provinsi	Penanggungjawab Bina Wilayah Tingkat Provinsi yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi
Tingkat Kabupaten/Kota	Penanggungjawab Bina Wilayah Tingkat Provinsi yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota
Tingkat Puskesmas	Kepala Puskesmas

D. Mekanisme Monitoring dan Evaluasi PIS-PK

1. Pelaksanaan pelatihan keluarga sehat dalam mendukung PIS-PK
2. Pelaksanaan persiapan PIS-PK
3. Pelaksanaan kunjungan keluarga dan intervensi awal PIS-PK
4. Pelaksanaan Analisis Indeks Keluarga Sehat (IKS) Awal
5. Pelaksanaan Intervensi Lanjut PIS-PK
6. Pelaksanaan Analisis Perubahan IKS

E. Tahap Pelaksanaan Pelatihan Keluarga Sehat dalam mendukung PIS-PK

Monitoring dan evaluasi dilakukan pada tahapan:
Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pelatihan dilaksanakan untuk Tingkat pusat

Tujuan	: Menilai kesesuaian pelaksanaan pelatihan Keluarga Sehat (KS) terhadap kurikulum yang ditetapkan
Jadwal	: Menyesuaikan dengan jadwal pelatihan KS masing-masing lokus
Lokasi	: Sesuai dengan Lokasi pelatihan
Frekuensi	: Sesuai dengan jumlah penyelenggara pelatihan
Indicator	: 1. Jumlah peserta yang hadir sesuai yang direncanakan 2. Jumlah peserta sesuai dengan persyaratan/kriteria yang ditetapkan 3. Jumlah peserta yang mengalami peningkatan kemampuan atau kompetensi sesuai dengan kurikulum 4. Materi yang diberikan sesuai dengan Garis Besar Proses Pembelajaran (GBPP) 5. Fasilitator memiliki kualifikasi sesuai dengan yang ditentukan
Pelaksana monitoring dan evaluasi	: Tim bina wilayah

Koordinator : Badan PPSPDMK
analisis hasil
monitoring dan
evaluasi pelatihan

Langkah-langkah monitoring dan evaluasi pelatihan:

- a. Penyiapan instrument monitoring dan evaluasi pelatihan
- b. Penjadwalan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelatihan
- c. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi (pengumpulan hasil kunjungan keluarga sesuai dengan instrument) oleh masing-masing penanggungjawab Bina Wilayah hasil monitoring dan evaluasi kepada koordinator
- d. Pengumpulan hasil monitoring dan evaluasi oleh koordinator
- e. Pelaksanaan analisis hasil monitoring dan evaluasi oleh koordinator
- f. Penyampaian hasil analisis monitoring dan evaluasi ke masing-masing penanggungjawab Bina Wilayah
- g. Penanggungjawab bina wilayah melakukan tindak lanjut hasil analisis pada provinsi binaan masing-masing

1. Tahapan pelaksanaan persiapan PIS-PK

Tujuan : Melihat pelaksanaan persiapan PIS-PK di masing-masing level (provinsi, kabupaten/kota dan puskesmas)

Jadwal : Menyesuaikan setelah pelaksanaan pelatihan bagi Puskesmas

Lokasi : Masing-masing lokus Binwil

Frekuensi : Sekali dalam setahun

Responden : Pimpinan atau penanggungjawab PIS-PK yang ditunjuk pada masing-masing tingkat

Indikator :

a. Tingkat provinsi

- 1) Terlaksananya sosialisasi di Tingkat Provinsi baik sosialisasi internal maupun eksternal
- 2) Adanya penanggungjawab/coordinator PIS-PK di Tingkat provinsi
- 3) Ketersediaan anggaran yang terintegrasi untuk pelaksanaan PIS-PK di Tingkat Provinsi
- 4) Tersedianya roadmap pemenuhan kebutuhan untuk pelaksanaan pelayanan Kesehatan (sarana-prasarana, alat Kesehatan dan SDM) di Tingkat Provinsi
- 5) Tersedianya alat Kesehatan yang mendukung pelayanan kesehatan

b. Tingkat Kabupaten/kota

- 1) Terlaksananya sosialisasi di Tingkat Kabupaten/Kota (baik sosialisasi internal maupun eksternal)
- 2) Adanya penanggungjawab/coordinator PIS-PK di Tingkat Kabupaten/kota
- 3) Ketersediaan anggaran yang terintegrasi untuk pelaksanaan PIS-PK di Tingkat Kabupaten/Kota
- 4) Tersedianya formulir Prokesga (tercetak/manual) atau elektronik (aplikasi Keluarga Sehat) untuk kebutuhan Puskesmas
- 5) Tersedianya Pinkesga (Paket Informasi Kesehatan Keluarga) untuk kebutuhan Puskesmas

- 6) Tersedianya *roadmap* pemenuhan kebutuhan untuk pelaksanaan pelayanan Kesehatan (sarana prasarana, alat Kesehatan dan SDM) di Tingkat kabupaten/kota
 - 7) Tersedianya alat Kesehatan yang mendukung pelayanan Kesehatan pada setiap Puskesmas yang menjadi lokus PIS-PK
- c. Tingkat Puskesmas
- 1) Terlaksananya sosialisasi di Tingkat Puskesmas (baik sosialisasi internal maupun eksternal)
 - 2) Adanya Penanggungjawab/koordinator PIS-PK di Tingkat Puskesmas
 - 3) Adanya koordinator dan tim Pembina keluarga di Puskesmas
 - 4) Ketersediaan anggaran yang terintegrasi untuk pelaksanaan PIS-PK di Tingkat Puskesmas
 - 5) Tersedianya formulir Prokesga (tercetak/manual) atau elektronik (aplikasi Keluarga Sehat)
 - 6) Tersedianya Pinkesga (Paket Informasi Kesehatan Keluarga)
 - 7) Tersedianya roadmap pemenuhan kebutuhan untuk pelaksanaan pelayanan Kesehatan (sarana-prasarana, alat Kesehatan dan SDM) di Tingkat Puskesmas
 - 8) Tersedianya alat Kesehatan yang mendukung pelayanan Kesehatan

Pelaksana monitoring dan evaluasi : Tim Bina Wilayah

Koordinator analisis hasil monitoring dan evaluasi : Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan

Langkah-langkah monitoring dan evaluasi pelaksanaan persiapan:

- a. Penyiapan instrument monitoring dan evaluasi
- b. Penentuan Lokasi kunjungan monitoring dan evaluasi dengan menggunakan metode sampling untuk level Kabupaten/Kota dan Puskesmas
- c. Penjadwalan pelaksanaan monitoring dan evaluasi
- d. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi (pengumpulan hasil kunjungan keluarga sesuai dengan instrument) oleh masing-masing penanggungjawab Bina Wilayah
- e. Pengumpulan hasil monitoring dan evaluasi kepada koordinator
- f. Pelaksanaan analisis hasil monitoring dan evaluasi oleh koordinator
- g. Penyampaian hasil analisis monitoring dan evaluasi ke masing-masing Provinsi binaan masing-masing penanggungjawab Bina Wilayah
- h. Penanggungjawab Bina Wilayah melakukan tindak lanjut hasil analisis provinsi binaan masing-masing

2. Tahapan pelaksanaan kunjungan keluarga dan intervensi awal PIS-PK

Tujuan : Memantau pelaksanaan kunjungan keluarga yang dilakukan oleh tenaga Kesehatan Puskesmas yang sekaligus dapat memberikan intervensi awal terhadap permasalahan Kesehatan yang ada di setiap anggota keluarga. Kondisi Kesehatan keluarga dan permasalahannya akan dicatat pada Profil Kesehatan Keluarga (Prokesga), yang

akan menjadi acuan dalam melakukan evaluasi dan intervensi lanjut. Puskesmas akan memonitor kondisi Kesehatan setiap keluarga di wilayah kerjanya melalui kunjungan ulang secara berkala untuk meningkatkan pencapaian Indeks Keluarga Sehat (IKS)

- Jadwal : Menyesuaikan jadwal pelaksanaan kunjungan keluarga atau setelah selesai pelaksanaan kunjungan keluarga oleh Puskesmas
- Frekuensi : Setahun sekali
- Lokasi : Sampling random yang dapat menggambarkan keterwakilan lokus di setiap Provinsi dan Kabupaten/Kota
- Responden : Pimpinan Puskesmas, Pembina Keluarga dan atau tim/program/satuan pelaksana sebagai penanggungjawab PIS-PK di Tingkat Puskesmas

Indikator:

- a. Terlaksananya kunjungan keluarga dan sekaligus intervensi awal pada seluruh keluarga di wilayah kerja Puskesmas
- b. Teridentifikasinya masalah Kesehatan di keluarga dari hasil pengumpulan informasi Kesehatan seluruh anggota keluarga terhadap 12 indikator Kesehatan keluarga dan masalah Kesehatan lainnya
- c. Penggunaan formulir Prokesga (tercetak/manual) atau elektronik (aplikasi Keluarga Sehat) saat kunjungan keluarga

- d. Penggunaan Pinkesga (Paket Informasi Kesehatan Keluarga) saat kunjungan keluarga
- e. Tersedianya alat Kesehatan yang mendukung pelaksanaan kunjungan keluarga
- f. Terlaksananya system rujukan ke fasilitas pelayanan Kesehatan bagi kasus yang memerlukan rujukan
- g. Terbinanya seluruh keluarga melalui kunjungan ulang secara berkala sesuai kebutuhan
- h. Adanya rekapitulasi informasi hasil kunjungan keluarga di pangkalan data Puskesmas

Pelaksana Monitoring dan : Tim Bina Wilayah
Evaluasi

Koordinator analisis hasil : Kesehatan,
monitoring dan evaluasi Kementerian
Kesehatan

Langkah-langkah monitoring dan evaluasi pelaksanaan kunjungan keluarga:

- a. Penyiapan instrument monitoring dan evaluasi
- b. Penentuan Lokasi kunjungan monitoring dan evaluasi dengan menggunakan metode sampling (random atau purposive) untuk level Kabupaten/Kota dan Puskesmas
- c. Penjadwalan pelaksanaan monitoring dan evaluasi
- d. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi (pengumpulan data hasil Kunjungan Keluarga KS oleh masing-masing Penanggungjawab Bina Wilayah. Verifikasi hasil kunjungan Keluarga dilakukan terhadap keluarga yang menjadi sampling
- e. Pengumpulan hasil monitoring dan evaluasi kepada koordinator monitoring dan evaluasi

- f. Pelaksanaan analisis hasil monitoring dan evaluasi oleh koordinator monitoring dan evaluasi
- g. Penyampaian hasil analisis monitoring dan evaluasi ke masing-masing Penanggungjawab Bina Wilayah
- h. Penanggungjawab Bina Wilayah melakukan tindak lanjut hasil analisis pada Provinsi binaan masing-masing

3. Tahapan Pelaksanaan Intervensi Lanjut PIS-PK

- Tujuan : Mengetahui Upaya intervensi lanjut yang dilakukan oleh tiap level dalam menindaklanjuti hasil analisis
- Jadwal : Menyesuaikan jadwal setelah selesainya analisis IKS awal
- Frekuensi : Setahun sekali
- Lokasi : Menyesuaikan dengan Lokasi monev hasil analisis sesuai level
- Responden : Pimpinan atau penanggungjawab PIS-PK yang ditunjuk pada masing-masing tingkat

Indikator:

- a. Tingkat provinsi:
 - 1) Adanya rencana tindak lanjut berdasarkan hasil analisis pada perencanaan di Tingkat Provinsi
 - 2) Terlaksananya kegiatan intervensi sesuai dengan rencana tindak lanjut (penjadwalan intervensi, *Term of Reference* (TOR), laporan pelaksanaan) di Tingkat Provinsi
- b. Tingkat Kabupaten/Kota
 - 1) Adanya rencana tindak lanjut berdasarkan hasil analisis pada perencanaan di Tingkat Kabupaten/Kota

- 2) Terlaksananya kegiatan intervensi sesuai dengan rencana tindak lanjut (penjadwalan intervensi, *Term of Reference* (TOR), laporan pelaksanaan) di Tingkat Kabupaten/Kota
- c. Tingkat Puskesmas
 - 1) Adanya rencana tindak lanjut berdasarkan hasil analisis pada perencanaan di Tingkat Puskesmas
 - 2) Terlaksananya kegiatan intervensi sesuai dengan rencana tindak lanjut (penjadwalan intervensi, *Term of Reference* (TOR), laporan pelaksanaan) di Tingkat keluarga, desa/kelurahan dan Puskesmas

Pelaksana monitoring : Tim bina wilayah dan evaluasi

Koordinator analisis : Ditjen Kesehatan
 hasil monitoring dan masyarakat, Ditjen
 evaluasi Pencegahan dan
 Pengendalian
 Penyakit dan Ditjen
 Pelayanan
 Kesehatan,
 Kementerian
 Kesehatan

Langkah-langkah monitoring dan evaluasi pelaksanaan intervensi lanjut:

- a. Penyiapan instrument monitoring dan evaluasi pelaksanaan intervensi lanjut
- b. Lokus kunjungan sama dengan lokus keluarga pada tiap level
- c. Penjadwalan pelaksanaan monitoring dan evaluasi

- d. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi (pengisian instrument di tiap level dengan dilampiri bukti telusur) (Kemenkes RI, 2017)
- e. Pengumpulan hasil monitoring dan evaluasi kepada koordinator monitoring dan evaluasi
- f. Pelaksanaan analisis hasil monitoring dan evaluasi oleh koordinator monitoring dan evaluasi
- g. Penyampaian hasil analisis monitoring dan evaluasi ke masing-masing penanggungjawab bina wilayah
- h. Penanggungjawab bina wilayah melakukan tindak lanjut hasil analisis pada provinsi binaan masing-masing (Kemenkes RI, 2017)

Bab 5

Penutup

Pemanfaatan pangan lokal merupakan salah satu cara dalam meningkatkan gizi balita. Melalui pendekatan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga, para ibu diajarkan untuk mengelola pangan lokal sebagai makanan tambahan bagi balita dalam peningkatan status gizi nya. Efek kekurangan gizi dapat memengaruhi perkembangan otak anak. Faktanya, periode emas perkembangan otak terjadi selama masa bayi. Masalah gizi tidak hanya memengaruhi perkembangan otak, tetapi juga dapat memengaruhi perilaku, kapasitas dan produktivitas kerja, serta daya tahan terhadap infeksi. Malnutrisi masih menjadi masalah yang tersebar luas di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Masalah yang disebabkan oleh asupan gizi yang tidak memadai meliputi kekurangan energi protein (KEP), kekurangan vitamin A (KVA), kekurangan yodium (GAKI), dan anemia.

Buku ini ditulis dengan mengedepankan pentingnya status gizi balita yang dapat ditingkatkan dengan menggunakan pendekatan PIS-PK yang focus pelayanannya adalah pada keluarga. PIS-PK merupakan sebuah program pemerintah yang dirancang dan dibuat mengingat masih banyaknya masalah yang terjadi pada balita yang salah satunya adalah masalah gizi kurang. Salah satu alternatif yang dapat dibuat dalam rangka meningkatkan status gizi balita yaitu

dengan pemberian makanan tambahan dalam bentuk pangan lokal. Indonesia merupakan negara agraris yang menghasilkan begitu banyak hasil pangan yang mempunyai nilai gizi yang baik dan dapat dimanfaatkan melalui pengolahan yang menarik agar dapat dikonsumsi oleh semua balita termasuk balita dengan status gizi kurang. Melalui pendekatan PIS-PK yang langsung menysasar keluarga, diharapkan agar para ibu balita dengan gizi kurang dapat memanfaatkan pangan lokal sebagai makanan tambahan maupun makanan pendamping yang bisa dikonsumsi oleh balita. Melalui pendekatan ini para ibu dapat memanfaatkan pangan lokal yang tersedia di pekarangan rumah sehingga meminimalisir anak mengkonsumsi jajanan yang tidak sehat. Para ibu diajarkan bagaimana mengolah dan menafatkan pangan lokal dengan baik. Selain manfaat bagi ibu, manfaat yang lain juga bisa dirasakan oleh balita gizi kurang, bahwa dengan pengolahan yang baik dengan mempertimbangkan nilai gizi, rasa dan modifikasi warna yang menarik dapat merangsang balita dalam mengkonsumsi pangan lokal.

Harapan kami agar melalui buku ini dapat menjadi sumber referensi bagi semua pihak terkait dalam hal ini keluarga, tenaga Kesehatan dan masyarakat secara umum dalam Upaya pemenuhan gizi bagi balita gizi kurang. Kami juga merekomendasikan dampak dari penelitian ini dengan beberapa Langkah konkrit diantaranya:

1. Adanya *follow up* yang dilakukan secara berkesinambungan untuk meningkatkan pemahaman ibu balita tentang masalah gizi kurang dalam memanfaatkan pangan lokal melalui PIS-PK.

2. Pemanfaatan teknologi sebagai alat bantu pembelajaran dan pemantauan status gizi.
3. Kolaborasi keluarga dengan tenaga Kesehatan dalam memantau status gizi balita.
4. Kegiatan ini diharapkan agar didukung dengan kebijakan yang mengikat sehingga menjadi suatu pola kebiasaan yang baik bagi ibu dan balita.

Masalah gizi kurang tidak hanya menjadi masalah Kesehatan, namun sudah menjadi masalah Kesehatan sehingga menjadi tanggung jawab semua pihak agar permasalahan ini dapat teratasi dengan baik. Melalui pendekatan PISPK, para ibu dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan sehingga dapat memanfaatkan pangan lokal dengan baik yang dapat dikonsumsi oleh balita sehingga pemenuhan gizi dapat maksimal

Kami mengucapkan terma kasih kepada seluruh pihak dan pembaca sehingga pemanfaatan pangan lokal ini dapat memberikan manfaat yang nyata bagi semua pihak yang terlibat.

Daftar Pustaka

- Atrium Health. (2021). *Daily Dose - A Guide to Toddler's Motor Skills Development by Age*.
- CDC. (2022). CDC's Developmental Milestones | CDC. In *National Center on Birth Defects and Developmental Disabilities, Centers for Disease Control and Prevention*.
<https://www.cdc.gov/ncbddd/actearly/milestones/index.html>
- Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat, & Anak, D. G. dan K. I. dan. (2024). *Website Gizi dan KIA - Index*.
<https://gizikia.kemkes.go.id/>
- DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN. (2019). *PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 29 TAHUN 2019 TENTANG PENANGGULANGAN MASALAH GIZI BAGI ANAK AKIBAT PENYAKIT* (pp. 1–23).
- Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat, & Direktur Gizi Masyarakat. (2020). *Pencegahan Dan Tata Laksana Gizi Buruk Pada Balita Di Layanan Rawat Jalan Bagi Tenaga Kesehatan*.
- dr. Makarim, F. R. (n.d.). *Mengenal Masa Toddler, Ciri-Ciri dan Indikator Perkembangannya*.
- Hartati, N. S., Sulistiowati, E., & Susilawati, M. D. (2021). Pelaksanaan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK) di Puskesmas. *Media Penelitian Dan Pengembangan Kesehatan*, 31(3), 161–170. <https://doi.org/10.22435/mpk.v31i3.3381>
- Hedianti, D. R., Varera, Y. E., & Rachmah, Q. (2023). Edukasi dan Demo Masak Pada Ibu Hamil dan Menyusui Tentang ASI Eksklusif dan Stunting di Kelurahan Rungkut Tengah Kota Surabaya. *Media Gizi Kesmas*, 12(2), 980–987.
<https://doi.org/10.20473/mgk.v12i2.2023.980-987>
- Herlambang, A., Wandini, R., & Setiawati, S. (2021). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Status Gizi Balita Di Puskesmas Krui Kabupaten

- Pesisir Barat. *Jurnal Kebidanan Malahayati*, 7(4), 673–680.
<https://doi.org/10.33024/jkm.v7i4.4407>
- Herrera-Cuenca, M. (2021). Understanding children's undernutrition in Venezuela. *EBioMedicine*, 67, 103367.
<https://doi.org/10.1016/j.ebiom.2021.103367>
- Iqrimah, A. N. (2024). *Pangan Lokal Kaya Gizi, Kenali Jenis dan Inovasinya yang Menggugah Selera*.
- kemkes. (2023). *Pemantauan Status Gizi Pada Lansia*.
- Kemkes R1. (2019). Profil kesehatan Indonesia 2019. In *Kementrian Kesehatan Republik Indonesia*.
<https://pusdatin.kemkes.go.id/resources/download/pusdatin/profil-kesehatan-indonesia/Profil-Kesehatan-indonesia-2019.pdf>
- Kemkes RI. (2017). Pedoman Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Indonesia Sehat Dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK). In *Kemkes RI*.
- Kementerian Kesehatan, 2024. (n.d.). *Buku Monitoring dan Evaluasi Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK)*.
- Lesmono, R. (2024). *Definisi Gizi Menurut WHO - RedaSamudera*.
- Nasehat.id. (2022). *Nutrisi untuk Balita, Gizi Terpenuhi, Baik Bagi Tumbuh Kembangnya*.
- Nuryuliani, E. (2024). Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan. In *Kemkes Direktorat Jendral Pelayanan Kesehatan* (pp. 1–5).
https://yankes.kemkes.go.id/view_artikel/1149/intoksikasi-alkohol
- Positive Parenting Tips | Child Development | CDC*. (n.d.).
<https://www.cdc.gov/child-development/positive-parenting-tips/index.html>
- Pratiwi, S. N. (2023). Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Status Gizi Balita Usia 3-5 Tahun. *Nutrizone (Nutrition Research and Development Journal*, 3(2), 10–21.

<https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/nutrizione/>

PSG. (2017). Hasil Psg 2017. *Buku Saku Pemantauan Status Gizi Tahun 2017*, 7–11.

Pusat Kesehatan dan Gizi Manusia, U. (2014). *Manfaat Diversifikasi Pangan Lokal Terhadap Kesehatan - PKGM*.

Sari, Y., Haryati, S., Setyawan, S., Prasita Negara, K. S., Dirgahayu, P., Wijayanti, L., Ma'rufah, S., Listyaningsih S, E., Riyadi, S., Supriyana, D. S., & Purnomo, S. (2022). Pemberdayaan Kader Kesehatan untuk Mendukung Program Indonesia Sehat melalui Pendekatan Keluarga (PISPK) dan Tatalaksana Diabetes Mellitus (DM), Hipertensi dan Merokok. *Smart Society Empowerment Journal*, 2(2), 49. <https://doi.org/10.20961/ssej.v2i2.61678>

Sutrisno, E., Dewi, D. O., Ariani, M., Sayekti, W. D., Lestari, D. A. H., Syafani, T. S., Triyanti, R., Wijaya, R. A., Zamroni, A., Ramadhan, A., Apriliani, T., Huda, H. M., Pramoda, R., Pramono, L. H., Koeshendrajana, S., Anggraeni, A., Yuniati, R., Silalahi, M., Irwandi, A., ... Hassanah, I. F. (2023). Diversifikasi Pangan Lokal untuk Ketahanan Pangan: Perspektif Ekonomi, Sosial, dan Budaya. In *Diversifikasi Pangan Lokal untuk Ketahanan Pangan: Perspektif Ekonomi, Sosial, dan Budaya* (Issue December). <https://doi.org/10.55981/brin.918>

Toddlers _ Psychology Today. (n.d.).

Troeger, C., Colombara, D. V., Rao, P. C., Khalil, I. A., Brown, A., Brewer, T. G., Guerrant, R. L., Houpt, E. R., Kotloff, K. L., Misra, K., Petri, W. A., Platts-Mills, J., Riddle, M. S., Swartz, S. J., Forouzanfar, M. H., Reiner, R. C., Hay, S. I., & Mokdad, A. H. (2018). Global disability-adjusted life-year estimates of long-term health burden and undernutrition attributable to diarrhoeal diseases in children younger than 5 years. *The Lancet Global Health*, 6(3), e255–e269. [https://doi.org/10.1016/S2214-109X\(18\)30045-7](https://doi.org/10.1016/S2214-109X(18)30045-7)

Ummah, M. S. (2019). Buku Pedoman Gizi Seimbang. In *Sustainability (Switzerland)* (Vol. 11, Issue 1). <http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RE>

D2017-Eng-
8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.
1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.
net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSA
T_STRATEGI_MELESTARI

UNICEF. (2024a). *At-Risk Mothers and Infants Under Six Months in Indonesia*.

UNICEF. (2024b). Kenali Faktor Risiko yang Dapat Menyebabkan Balita Mengalami Wasting (Gizi Kurang dan Gizi Buruk). In *Unicef* (pp. 1–13).

UNICEF Parenting. (n.d.). *Your toddler's developmental milestones at 1 year* / *UNICEF Parenting*.
<https://www.unicef.org/parenting/child-development/your-toddlers-developmental-milestones-1-year#social-and-emotional>

Unika, P. (2006). *Edition. Chapman and Hall. Bourne, M. C. (2002). Food Texture and Viscosity Concept and Measurement 2. 2002.*

WHO. (n.d.). *Weight-for-age*.

WikiPangan. (2018). *Pangan Lokal - WikiPangan*.

Glosarium

A

ASI: nutrisi yang optimal untuk bayi. Selain nutrisi penting (protein, lemak, karbohidrat, vitamin dan mineral), ASI juga mengandung berbagai sel kekebalan dan komponen bioaktif yang memiliki tindakan anti-inflamasi, anti-infeksi dan probiotik.

Antropometri: merupakan sebuah metode yang digunakan untuk mengukur dimensi fisik manusia. Pengukuran ini meliputi berbagai aspek seperti tinggi badan, berat badan, lingkar tubuh, lebar bahu, dan panjang lengan.

B

Balita: anak-anak berusia antara 1 hingga 5 tahun. Pada periode ini, anak-anak masih dalam tahap pertumbuhan dan perkembangan yang pesat.

J

JKN: adalah program pemerintah yang bertujuan untuk memberikan perlindungan kesehatan kepada seluruh penduduk Indonesia.

K

Kalsium: adalah salah satu mineral yang sangat penting bagi kesehatan tubuh manusia. Mineral ini memiliki peran yang sangat vital dalam menjaga kesehatan tulang dan gigi, serta berperan dalam menjaga fungsi saraf, otot, dan jantung.

M

Malnutrisi: salah satu kondisi yang berbahaya, yakni ketika seseorang mengalami ketidakseimbangan nutrisi dalam tubuhnya

N

Nutrisi: adalah kandungan zat gizi yang seseorang peroleh dari sumber makanan dan minuman yang berguna untuk kesehatan dan pembangunan sel tubuh.

P

Pangan Lokal: adalah makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat setempat sesuai dengan potensi dan kearifan lokal.

PIS-PK: adalah Program Indonesia Sehat merupakan salah satu program dari Agenda ke-5 Nawa Cita, yaitu Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia Indonesia.

S

Status Gizi: status gizi berarti keadaan kesehatan fisik seseorang atau sekelompok orang yang ditentukan dengan salah satu atau dua kombinasi dari ukuran-ukuran gizi tertentu.

Profil Penulis



Yosephina Maria Hawa Keytimu, S.Kep., Ns., M.P.H. Lahir di Maumere, 26 Juli 1977. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang S1 pada Program Studi Sarjana Ilmu Keperawatan dan Profesi Ners Universitas Nusa Nipa lulus tahun 2010. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 pada Universitas Gadjah Mada tahun 2015 dan lulus tahun pada tahun 2017.

Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 2011 sebagai tenaga pendidik di di Program Studi Sarjana Ilmu Keperawatan Universitas Nusa Nipa, kemudian menjadi dosen tetap di Universitas Nusa Nipa sejak tahun 2012 sampai dengan sekarang. Saat ini penulis bekerja di Universitas Nusa Nipa sebagai dosen pengampu mata kuliah Keperawatan keluarga dan Komunitas. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai pengajar, penulis buku, sebagai pembicara maupun peserta di seminar-seminar nasional maupun internasional. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: fienkeytimu@gmail.com

Motto: "Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namaNya"

Profil Penulis



Yustina Yantiana Guru, S. Kep., Ns., M.Kep. Lahir di Maumere, 15 April 1987.

Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang S1 pada Program Studi Sarjana Ilmu Keperawatan dan Profesi Ners Universitas Nusa Nipa lulus tahun 2010. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 pada Universitas Padjajaran tahun 2011 dan lulus tahun pada tahun 2013. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 2011 sebagai tenaga pendidik di di Program Studi Sarjana Ilmu Keperawatan Universitas Nusa Nipa, kemudian menjadi dosen tetap di Universitas Nusa Nipa sejak tahun 2012 sampai dengan sekarang. Saat ini penulis bekerja di Universitas Nusa Nipa sebagai dosen pengampuh mata kuliah Keperawatan Kritis dan Kegawatdaruratan. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai pengajar, penulis buku, sebagai pembicara maupun peserta di seminar-seminar nasional maupun internasional. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: yustinaunipamaumere@gmail.com

SINOPSIS BUKU

Buku ini membahas tentang pentingnya Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga dalam Upaya meningkatkan status gizi balita menggunakan pangan berbahan dasar lokal yang bisa dijumpai sehari-hari dan mudah diperoleh. Status gizi balita merupakan suatu kondisi tentang gizi balita yang dapat diukur melalui pengukuran antropometri yaitu BB/Usia. Buku ini mengajak para pembaca dalam memahami konsep dasar status gizi balita, manfaat gizi, factor-faktor yang menyebabkan gizi kurang serta Upaya pencegahan yang dapat dilakukan

Salah satu Upaya pencegahan yaitu dengan meningkatkan pengetahuan ibu dalam memberi makan balita gizi kurang berbahan dasar pangan lokal melalui pendekatan keluarga.

Keluarga terutama Ibu merupakan garda terdepan bagi perkembangan anak dan nutris yang dibutuhkan oleh balita.

Melalui pendekatan PISPK, para ibu balita dapat lebih meningkatkan pengetahuan dan keterampilannya dalam mengolah pangan lokal menjadi makanan tambahan bagi balita. Pangan lokal dapat diolah dengan cita rasa yang berbeda untuk menggugah nafsu makan anak serta ditampilkan dengan tampilan yang menarik sehingga menjadikan anak minat mengkonsumsi makanan yang diolah berbahan pangan lokal.

Buku ini selain menyasar individu sebagai pembaca, tetapi lebih dari itu memberi wawasan kepada semua pihak dalam Upaya menurunkan angka kejadian gizi kurang pada balita

Buku ini membahas tentang pentingnya Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga dalam Upaya meningkatkan status gizi balita menggunakan pangan berbahan dasar lokal yang bisa dijumpai sehari-hari dan mudah diperoleh. Status gizi balita merupakan suatu kondisi tentang gizi balita yang dapat diukur melalui pengukuran antropometri yaitu BB/Usia. Buku ini mengajak para pembaca dalam memahami konsep dasar status gizi balita, manfaat gizi, factor-faktor yang menyebabkan gizi kurang serta Upaya pencegahan yang dapat dilakukan

Salah satu Upaya pencegahan yaitu dengan meningkatkan pengetahuan ibu dalam memberi makan balita gizi kurang berbahan dasar pangan lokal melalui pendekatan keluarga. Keluarga terutama Ibu merupakan garda terdepan bagi perkembangan anak dan nutris yang dibutuhkan oleh balita. Melalui pendekatan PISPK, para ibu balita dapat lebih meningkatkan pengetahuan dan keterampilannya dalam mengolah pangan lokal menjadi makanan tambahan bagi balita. Pangan lokal dapat diolah dengan cita rasa yang berbeda untuk menggugah nafsu makan anak serta ditampilkan dengan tampilan yang menarik sehingga menjadikan anak minat mengkonsumsi makanan yang diolah berbahan pangan lokal.

Buku ini selain menyasar individu sebagai pembaca, tetapi lebih dari itu memberi wawasan kepada semua pihak dalam Upaya menurunkan angka kejadian gizi kurang pada balita.

Penerbit:
PT Nuansa Fajar Cemerlang
Grand Slipi Tower Lt. 5 Unit F
Jalan S. Parman Kav. 22-24
Kel. Palmerah, Kec. Palmerah
Jakarta Barat, DKI Jakarta, Indonesia, 11480
Telp: (021) 29866919



ISBN 978-634-7097-61-3



9

786347

097613